

1
1 point
MCA



Un homme de 65 ans, fumeur, se présente pour **une dyspnée effort progressive** depuis **quelques mois**. Il ne présente pas d'angor pectoral, ni de dyspnée paroxysmique nocturne, ni d'œdème des membres inférieurs. À l'examen physique, les signes vitaux sont normaux. Vous notez un léger râge avec une **raupetée inspiratoire à l'inspiration**. Quelle est votre conduite ?

- ☐ A) Dosage du NT-BNP
- ☐ B) Échographie cardiaque
- ☒ C) Laryngobronchoscopie
- ☐ D) Spirométrie

2
1 point
MCA



Une patiente de 51 ans vous rencontre pour le suivi d'un **diabète** connu depuis l'âge de 33 ans. Elle a été traitée initialement par des hypoglycémiants oraux et elle prend maintenant de l'insuline. Sa Tn est à 120/75 mmHg. Son HbA1c est à 6,9% (N : 4,9-6,0%) et elle fait environ une hypoglycémie par mois. Elle fait de l'exercice trois fois par semaine sans problème. Quel examen de dépistage est indiqué ?

- ☐ A) Coloscopie urinaire de 24 heures pour recherche de proctinurie
- ☐ B) Épreuve d'effort (bapté roulet)
- ☒ C) Examen des pieds avec monofilament
- ☐ D) Index brachialve

3
1 point
MCA



Un patient **diabétique** de 48 ans se plaint de **symptômes nouveaux** importants. Il est actuellement traité avec de **l'empagliflozine**, du **glucoside**, de **l'insuliglisine** et de **la metformine** au coucher. Quel médicament est le plus probablement en cause ?

- ☐ A) Empagliflozine
- ☒ B) Glucoside
- ☐ C) Insuline
- ☐ D) Metformine

4
1 point
MCA



Une patiente diabétique de 56 ans est traitée avec de la metformine, du glucoside, de l'empagliflozine et de la sitagliptine. Elle présente des infections urinaires à **leucocytes** récurrentes. Quel médicament est le plus probablement responsable de ces infections ?

- ☐ A) Empagliflozine
- ☐ B) Glucoside
- ☐ C) Metformine
- ☒ D) Sitagliptine

5
1 point
MCA



Une femme de 65 ans, diabétique, se présente avec un tableau **polyaffectif** d'expression. On note à l'examen une tension artérielle à **90/60**, une **hyperémie cutanée** prédominamment **trigémico-faciale**, avec signes vitaux sont normaux. Les paires crâniennes sont normales. Dans quel territoire vasculaire cérébral se situe vraisemblablement le problème ?

- ☐ A) Arctie cérébrale moyenne droite
- ☒ B) Arctie cérébrale moyenne gauche
- ☐ C) Arctie cérébrale postérieure droite
- ☐ D) Arctie cérébrale postérieure gauche

6
1 point
MCA



Une femme de 28 ans présente **des nodules, fermes et roses** au niveau des têtes. Ces nodules sont **douloureux et sensibles** à la palpation. Laquelle des conditions suivantes peut être en cause ?



- ☒ A) Diabète sucré
- ☐ B) Eczéma
- ☐ C) Psoriasis
- ☐ D) Sarcoidose

7
1 point
MCA



Une femme de 67 ans est au 7e jour post-opératoire d'une **hystérectomie totale** pour une néoplasie colique. Elle **se réveille** en présence de 9 à 10 selles **liquides** par jour depuis quelques jours. Son **taux de créatinine** est **stable**, mais **taux de sodium** bien sanguin Na 132 mmol/L (N : 135-145), K 3,8 mmol/L (N : 3,5-5,1), Cl 106 mmol/L (N : 95-105), **taux de potassium** 2,7 mmol/L (N : 4,0-5,0), **taux de magnésium** 0,42 mmol/L (N : 0,75-1,05), **taux de calcium** 1,97 mmol/L (N : 2,2-2,6). Quelle est la cause la plus probable de son problème ?

- ☒ A) Diarrhée
- ☐ B) Insuffisance rénale
- ☐ C) Hypomagnésémie
- ☐ D) Surdosage de fentanyl

8
1 point
MCA



Un patient de 67 ans présente un tableau clinique de confusion et de céphalée. Vous avez les résultats de sa ponction lombaire (cf. plus bas). Quel est le diagnostic le plus probable ?

Pression d'ouverture : 28 cm H₂O

Liquide céphalo

Hémocrit : 750 champ

Globules blancs : 2500 champ (polynucléaires 10% et mononucléaires 90%)

Protéines : 1,4 g/L (N : 0,4-0,6 g/L)

Cytocentrifuge : normale

- ☐ A) Accidents vasculaires cérébraux
- ☐ B) Endophtalme herpétique
- ☐ C) Méningisme sous-dural
- ☒ D) Méningite bactérienne

9
1 point
MCA



Un homme de 78 ans se présente pour fatigue importante. Il a subi un **accident vasculaire cérébral** métabolique il y a 1 an pour lequel il est **traité** avec de l'acétazolamide (anti-vitamine K). Le bilan sanguin initial démontre une **hémoglobine** à **13,5 g/dL** (N : 140-160) avec VGM (MCV) normal, les LDM sériques sont légèrement augmentés. Le bilan martial démontre une **saturation** à **44,5 mg/dL** (N : 25-275) et avec un indice de saturation à 0,58% (N : 0,15-0,55). Quelle est l'étiologie la plus probable de cette anémie ?

- ☐ A) Anémie inflammatoire
- ☒ B) Anémie sur une régénération pauvre
- ☐ C) Anémie par carence en fer
- ☐ D) Syndrome myélodysplasique

10
1 point
MCA



Une patiente de 68 ans vous a consulté pour **une hyperthyroïdisme** depuis quelques mois. Elle se sent plus **fatiguée** et a aussi l'habitude de fréquenter des **endocrinologues**. Elle a **perdu** au cours de la dernière année, sans d'être particulière. Signes vitaux : TC 100/min, TA 140/90. À l'examen physique, le **palpé** est **diffusément augmenté de volume**, non douloureux. Examen des yeux est normal. Les analyses biochimiques démontrent **taux de TSH** à **0,05 mIU/L** (0,34-4,26), T4 libre à **22,2 pmol/L** (9,0-16,5) et FT4 libre à **22,2 pmol/L** (9,0-16,5). Quelle est l'investigation suivante la plus appropriée ?

- ☐ A) Dosage de la thyroglobuline sérique
- ☐ B) Échographie thyroïdienne avec doppler
- ☒ C) Imagerie par résonance magnétique (IRM) de la thyroïde
- ☐ D) Scintigraphie thyroïdienne

11
1 point
M.C.A.

Une patiente de 51 ans est suivie pour une **hypertension artérielle** connue depuis l'âge de 33 ans. Elle a été traitée initialement par des hydrophtorésiques oraux et elle prend maintenant de l'insuline et de la Metformine. Elle fait de l'insuline trois fois par semaine sans problème. Sa Tn asa à 125/75 mmHg. Son **HbA1c** est à 6,76 % (**5,6 à 6,4**), elle a fait **deux** une **hypoglycémie** par mois. Son cholestérol total est à 5,3 mmol/L (N : <6,0) et ses LDL à 3,3 mmol/L. Ses bilans rénaux et urinaires sont normaux. Que lui recommander vous ?

- ☐ Ajout d'une statine
- ☐ Ajout d'aspirine
- ☒ Ajout d'un inhibiteur de la SGLT-2 (Sotaglutide ou empagliflozine)
- ☐ Ajout d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA)

12
1 point
M.C.A.

Un patient de 19 ans consulte à la clinique sans rendre vous parce qu'il pense avoir une **gonorée**. Il revient d'un séjour d'une semaine de vacances à **Guinée** 7 avant avoir obtenu **400 mg** à quelques reprises et se remet fermement d'une **gonorée** qui s'est accompagnée de **fièvre, douleurs articulaires, urticaire et érythème** pendant trois jours. Il a encore peu d'appâts, mais ne vomit plus et les selles sont maintenant normales. Signes vitaux : température 37,2°C, FC 72/min et Tn 115/70. Laboremens sont normal sans douleur, sans masse ni organomégalie. Vous mesurez son bilan sanguin (cf. plus bas). Quel est le diagnostic le plus probable ?

Bilan biologique : test **AS** positif (N : <32), indolence **SI** (N : 1-16), élévation **4** (N : 0-4)

ASAT 28 UI/L (N : <35), **ALAT** 25 UI/L (N : <35)

GGT 70 UI/L (N : <50), **Phosphatase alcaline** 105 UI/L (N : 35-105)

- ☐ Hépatite A
- ☐ Paludisme
- ☒ Sepsis hépatique atypique
- ☐ Syndrome de Gilbert

13
1 point
M.C.A.

Une femme de 58 ans présente un **arthralgie** et une **douleur aux articulations** inter-phalangiennes proximales et distales de plusieurs doigts des 2 mains. La **douleur persiste avec le repos**, mais s'aggrave avec la journée. La revue des systèmes est par ailleurs sans particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Arthrite psoriasique
- ☐ Arthrite post-traumatique
- ☒ Arthrose
- ☐ Polyarthrite rhumatoïdale

14
1 point
M.C.A.

Une patiente de 28 ans vient se consulter pour **hyperthyroïdisme** depuis quelques mois. Elle se sent plus **fatiguée** et a aussi noté de fréquents épisodes de **tachycardie**. Elle a **perdu 10 kg** au cours de la dernière année, sans diète particulière. Signes vitaux : FC 105/min, Tn 140/90. La **thyroïde** est ferme, **augmentée de volume de 50%**, sur laquelle on **palpe** un **nodule** en audible. Les analyses laboratoires démontrent : TSH 0,05 mIU/L (0,34-4,20), T4 libre 22,2 pmol/L (8,8-16,8) et B-HCG négatif. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Adénome thyroïdien
- ☒ Maladie de Basedow (ou Graves)
- ☐ Thyroïdite d'Hashimoto
- ☐ Thyroïdite subaiguë (de Quervain)

15
1 point
M.C.A.

Une patiente de 46 ans vous consulte au bureau pour une **épilepsie** depuis 7 jours, **survenant par la nuit**, réduite par le repos et **répétitive à 100**. Elle n'a aucun antécédent médical ou chirurgical pertinent. Examen physique démontre une **convulsion**, une **épilepsie** **tonicoclonique** à la **partir**, paroxysmale droite et des signes du triptode et de Lerdau positif. Examen neurologique est normal sauf pour une **hémiparésie** **comparative** du **bras et de la jambe** **du côté gauche**. Quelle est votre conduite ?

- ☐ Vous demandez un électroencéphalogramme
- ☒ Vous prescrivez une imagerie par résonance magnétique (IRM)
- ☐ Vous prescrivez un repos au lit pour 1 semaine
- ☐ Vous prélevez un rendez-vous d'ici 6 semaines en demandant à la patiente d'éviter les mouvements ou positions douloureuses et en expliquant les symptômes d'alarmes neurologiques

16
1 point
M.C.A.

Une femme de 78 ans consulte pour des **troubles aux épaules, aux bras et aux jambes**, progressifs depuis quelques semaines. Elle a aussi noté qu'elle a **perdu 15 kg** sans régime. Elle se plaint d'être couverte **de plaques** depuis qu'elle a eu de la **gonorée** pour un cancer du sein il y a 15 ans. Son mari est décédé il y a 6 mois des complications d'un AVC. Quel est le meilleur examen pour établir le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Examen mental
- ☐ Immuno-électrophorèse des protéines sériques
- ☐ Vitesse de sédimentation
- ☒ Scintigraphie osseuse

17
1 point
M.C.A.

Une femme de 74 ans se présente pour **troubles respiratoires chroniques** et **hyperlipémie** depuis quelques jours. Elle **se sent fatiguée** et connue pour **troubles respiratoires chroniques**. Signes vitaux : **température** 38,5°C, et **SpO2** 94% avec **3 L O2** par lunettes nasales. La radiographie pulmonaire démontre une **opacité antérieure au lobe inférieur droit avec un déplacement pleural** **modéré**. Les résultats d'une **ponction pleurale** draine diagnostique sont : **1000** (N : 7,5-10), **globules** 28 mmol/L (N : 3,2-12), LDH 550 U/L, protéines 20 g/L, Au niveau **alcalinité** 28 mmol/L (N : 3,2-4,5), LDH 220 U/L (N : <270), protéines 10 g/L (N : <30-35). Quelle sera votre prise en charge ?

- ☒ Antibiotique IV seulement
- ☐ Antibiotique IV et diurétique
- ☐ Antibiotique IV et corticostéroïde
- ☐ Antibiotique IV et drainage pleural

18
1 point
M.C.A.

Un patient de 66 ans, traité pour HTA et diabète, se présente pour des **troubles** depuis 3 jours. Il a été peu mangé. Il a continué sa médication (un diurétique, un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, une sulfaméthoxazole et une triméthoprim). À l'arrivée aux urgences, **100/70 mmHg** et FC à 100/min. Le temps de **prothrombine** **supérieur** **supérieur**. Une perfusion intraveineuse est débutée. Au bilan sanguin : **calcium** 2,0 mmol/L (N : 4,0-10,5), **potassium** 3,0 mmol/L (N : 3,8), Na 134 mmol/L (N : 135-145), **glucose** 6,3 mmol/L (N : 3,5-5,5). Un ECG est fait (voir ECG joint). Quelle est la mesure prioritaire ?



- ☐ Demander IV
- ☐ Digoxine
- ☒ Gluconate de calcium IV
- ☐ Fentanyl oral

19
1 point
M.C.A.

Un homme de 58 ans est renvoyé initialement par ses proches. Il n'avait pas été vu depuis 72 heures. À l'admission en salle de réanimation, signes vitaux : **FC** 95/min, **TA** 160/90, FR 16/min, SpO2 à 94% à l'air libre et **température rectale** à 36,3°C. Le **reflexe** **patellaire** **normal**. Les paires crâniennes sont normales. Il bouge les quatre membres à la douleur. Les réflexes sont lents et symétriques. Examen du cœur, des poumons et du abdomen est sans particularité. Quel diagnostic parmi les suivants est le plus probable ?

- ☐ Choc septique
- ☐ Endocardite fongique
- ☒ Hypothyroïdisme
- ☐ Status épileptique

20 1 point
MC-A

Un patient de 52 ans, sans antécédent, se présente pour un tableau de faiblesse et de malaise général. Il a présenté des diarrhées profuses pendant une semaine avec des crampes abdominales pour lesquelles il a pris quelques comprimés d'ibuprofène. Il urine très peu. Sa TA est à 88/50 mmHg. Les bilans suivants sont obtenus : créatinine 350 $\mu\text{mol/L}$ (N : 50-105), urée 20 mmol/L (N : 2,0-8,0), hémoglobine 140 g/L (N : 140-180), plaquettes $150 \times 10^9/\text{L}$ (N : 150-400). Sédiment urinaire : cylindres granuleux. Sodium urinaire 40 mmol/L . Quelle est la cause la plus probable de son état ?

- A ☒ Insuffisance rénale aigüe d'origine pré-rénale ☐
- B ☒ Nécrose tubulaire aigüe ☐
- C ☒ Néphrite interstitielle aux AINS ☐
- D ☒ Syndrome hémolytique urémique ☐

21 1 point
MC-A

Un patient de 46 ans se présente pour dyspnée et œdème généralisé. Il urine très peu depuis 24 heures. Signes vitaux : TA 180/95 mmHg, SpO_2 94% avec 4 litres d'oxygène. À l'examen physique, la pression veineuse jugulaire est élevée, il y a des crépitations aux bases pulmonaires et un œdème prenant le godet qui remonte jusqu'à mi-cuisse. Les examens sanguins montrent : créatinine 524 $\mu\text{mol/L}$ (N : 40-105), urée 34 mmol/L (N : 2,2-8,0), Na 134 mmol/L (N : 135-145), K 7,2 mmol/L (N : 3,5-5,2). Du sang et des protéines sont présents à l'analyse urinaire. La diurèse est de 100 ml pendant les 2 heures suivant l'administration d'une dose IV de furosémide. Que devrez-vous faire en priorité ?

- A ☒ Amorcer une dialyse ☐
- B ☒ Débuter un chélateur du potassium par voie orale (sulfonate de polystyrène) ☐
- C ☒ Débuter un anti-hypertenseur ☐
- D ☒ Répéter le furosémide IV ☐

22 1 point
MC-A

Une femme de 45 ans rapporte une faiblesse de sa jambe droite dans la période post-opératoire d'une hystérectomie par laparotomie. L'examen neurologique du membre inférieur droit révèle une faiblesse de la flexion de la hanche et de l'extension du genou ; la sensibilité est diminuée au versant antérieur et médial de la cuisse ; le réflexe rotulien est absent et le réflexe achilléen préservé. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A ☒ Neuropathie fémorale ☐
- B ☒ Plexopathie lombo sacrée ☐
- C ☒ Radiculopathie L4 ☐
- D ☒ Radiculopathie L5 ☐

23 1 point
MC-A



Un patient de 23 ans se présente pour une atteinte de l'état général avec un état fébrile depuis trois jours. La température est à 38,7 °C. L'examen physique révèle de petites adénopathies cervicales bilatérales. La formule sanguine montre des lymphocytes à $0,900 \times 10^9/L$ (N : 1,200-4,000), des neutrophiles à $4,000 \times 10^9/L$ (N : 2,000-6,500), une hémoglobine à 135 g/L (N : 140-180) et des plaquettes à $175 \times 10^9/L$ (N : 150-400). Le monostest est négatif. Quel est votre bilan prioritaire ?

- A ☒ Frottis de gorge avec culture ☐
- B ☒ LDH ☐
- C ☒ IgM cytomégalovirus ☐
- D ☒ IgM toxoplasmose ☐

24 1 point
MC-A

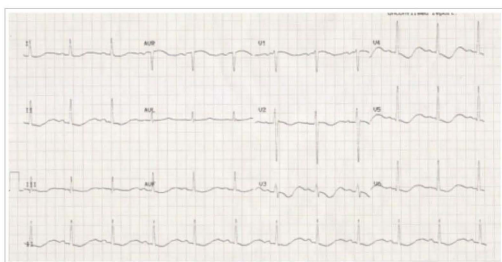


Une femme de 50 ans présente des douleurs aux membres inférieurs sous forme de « piqûres d'aiguille », à distribution en chaussettes, depuis la fin de sa chimiothérapie pour lymphome. Ces douleurs l'éveillent la nuit et ses analgésiques, paracétamol et morphine, ne lui apportent aucun soulagement. Quelle co-analgésie lui proposerez-vous ?

- A ☒ Anticonvulsivant ☐
- B ☒ Benzodiazépine ☐
- C ☒ Calcitonine ☐
- D ☒ Corticostéroïde ☐

25

Une femme de 33 ans se présente aux urgences pour de la faiblesse et des épisodes de lipothymie. Un ECG est effectué. Que suspectez-vous ?



- A ☒ Hypokaliémie sévère ☐
- B ☒ Hyperkaliémie sévère ☐
- C ☒ Infarctus inférieur aigu ☐
- D ☒ Péricardite ☐

26

1 point
MC-A

On amène aux urgences un patient de 30 ans pour des troubles de l'état de conscience. Il a convulsé 2 fois depuis 1 heure. L'examen physique est sans particularité. Il n'y a pas d'œdème, ni de signes de contraction volumique et l'examen neurologique ne révèle aucun signe localisateur. Vous avez son bilan laboratoire (voir LABO joint). Quel est le diagnostic le plus probable ?

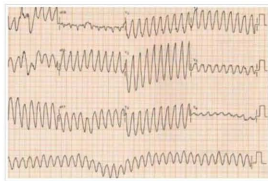
BIOCHIMIE GÉNÉRALE			ANALYSES URINAIRES	
Sodium	116 mmol/L	(135 - 145)	Sodium	10 mmol/L
Glucose	5,1 mmol/L	(3,3 - 6,1)	Osmolalité	60 mOsm/L
Créatinine	60 µmol/L	(60 - 115)		
Osmolalité	242 mOsm/L	(275 - 295)		
TSH	2,5 mIU/L	(0,25 - 5,0)		
Cortisol	250 nmol/L	(138 - 690)		
GAZ CAPILLAIRE				
pH	7,38	(7,33 - 7,43)		
pCO ₂	42 mmHG	(38 - 48)		
HCO ₃	23 mmol/L	(21 - 26)		

- A ☒ Hyponatrémie secondaire à un diurétique ☐
- B ☒ Intoxication médicamenteuse ☐
- C ☒ Polydipsie primaire ☐
- D ☒ Syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH) ☐

27

1 point
MC-A

Un homme de 38 ans se présente aux urgences pour des palpitations récurrentes. Il se sent faible pendant ces palpitations, mais n'a pas eu de douleur thoracique, de lipothymie ni de syncope. Lors de votre anamnèse, il se plaint soudainement de cette palpitation. L'ECG fait pendant les symptômes est disponible (voir ECG joint). L'épisode est auto résolusif et il n'a eu aucun autre symptôme. Les signes vitaux sont actuellement normaux. L'ECG post événement est normal. Quelle conduite recommandez-vous à ce stade-ci ?



- A ☒ Amiodarone pour prévenir la récurrence ☐
- B ☒ Cardioversion électrique immédiate à la prochaine récurrence ☐
- C ☒ Diltiazem pour prévenir la récurrence ☐
- D ☒ Metoprolol à la demande, pour traiter une récurrence ☐

28
Léon
MCA



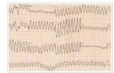
Au retour d'un voyage de plusieurs mois dans le sud de l'Inde, un jeune homme de 26 ans se présente pour une boite non dissimulée qui a grandi progressivement sur plusieurs semaines au niveau de son cou. Il se plaint aussi de légères douleurs abdominales. Il a perdu du poids et il se sent fatigué. Signes vitaux : température 38,0°C, TA 120/75, FC 95/min. À l'examen physique, il a plusieurs adénopathies cervicales dont une plus volumineuse de 7 cm en haut du cou. Il n'y a pas de signes de maladie systémique. Une biopsie de l'adénopathie cervicale et des prélèvements histologiques sont réalisés. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Maladie des griffes du chat
- ☒ Lymphome
- ☒ Sarcosiose
- ☒ Tuberculose

29
Léon
MCA



Un homme de 40 ans se présente aux urgences en raison d'une ischémie. Il est conduit en salle de réanimation avec une tension artérielle à 100/50 et une FC à 180/min. L'ECG est joint ci-dessous. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Fibrillation auriculaire avec altération de conduction
- ☒ Tachycardie atriale avec bloc de branche gauche
- ☒ Tachycardie ventriculaire
- ☒ Torsade de pointes

30
Léon
MCA



Une femme de 31 ans est à 31 semaines d'aménorrhée. Sa grossesse se déroule normalement et elle n'a aucune plainte. Voici les résultats de son hyperglycémie provoquée :

Glycémie à jeun : 4,2 mmol/L (N < 5,3)
Glycémie 1 heure : 10,2 mmol/L (N < 7,8)
Glycémie 2 heures : 8,2 mmol/L (N < 8,6 mmol/L)

Quelle est votre conduite ?

- ☒ Suivi des glycémies, consultation en diabétique, consultation en endocrinologie
- ☒ Suivi des glycémies, consultation en diabétique, consultation en endocrinologie et débiter les hyperglycémies orales
- ☒ Suivi des glycémies, consultation en diabétique, consultation en endocrinologie et débiter l'insulinothérapie
- ☒ Suivi normal de grossesse

31
Léon
MCA



Une femme de 35 ans consulte pour infertilité. Elle tente de devenir enceinte, mais sans succès malgré 30 mois d'essai. Ses cycles menstruels sont très espacés, environ 6 fois par année. À l'examen, vous notez des seins augmentés au toucher, à l'abdomen et aux cuisses. Son BMI est normal. Après avoir procédé à une investigation appropriée et normale, quel traitement lui proposez-vous pour aider considérablement que sa priorité actuellement est la fertilité ?

- ☒ Anti-androgène tel andarine de ciproterone
- ☒ Clomifène de clomifène
- ☒ Contraceptif oral avec drospirone
- ☒ Maffrenine

32
Léon
MCA



Une dame de 27 ans consulte pour être de grossesse depuis 6 mois. Elle a des cycles réguliers et son conjoint est en bonne santé. Quel lui recommandez-vous à cette étape-ci ?

- ☒ Hystéroscopie
- ☒ Induction
- ☒ Prendre de l'acide folique
- ☒ Spermiogramme pour son conjoint

33
Léon
MCA



Une femme de 27 ans a cessé la contraception orale combinée il y a 3 mois et ne présente toujours pas de menstruation. Elle n'a aucun partenaire sexuel. Elle avait des cycles réguliers auparavant. Son poids est stable depuis quelques années. Quelle serait votre conduite ?

- ☒ Dosage de LH
- ☒ Dosage de FSH
- ☒ Dosage de TSH
- ☒ Observer

34
Léon
MCA



Une patiente de 25 ans consulte votre cabinet pour des douleurs menstruelles depuis 2 ans, de plus en plus importantes, avec aussi douleurs lors des relations sexuelles. Elle a tenté un traitement avec des contraceptifs oraux cycliques et des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans succès. À l'examen gynécologique, le toucher vaginal est douloureux, sans autre anomalie. Une échographie pelvienne récente est normale. Elle ne présente pas de symptômes urinaires, ni digestifs. Vous devez confirmer votre diagnostic avant de prescrire un autre traitement, quel serait le meilleur examen ?

- ☒ Une imagerie par résonance magnétique (IRM) pelvienne
- ☒ Une hystéroscopie
- ☒ Une colposcopie avec biopsies dirigées
- ☒ Une tomographie par émission de positons (TEP)
- ☒ Un scanner pelvien

35

1 point
MCQ



Une fille de 15 ans présente des douleurs menstruelles depuis le début de sa vie. Son examen pelvien est normal. Que lui suggérez-vous ?

- ☒ Anti-inflammatoire non stéroïdien lors des menstruations
- ☒ Une laparoscopie diagnostique
- ☒ Un contraceptif au lévonorgestrel
- ☒ Un traitement par Vitamine B₆

36

1 point
MCQ



Une patiente de 42 ans se présente au bureau pour des envies urgentes d'uriner qui l'empêchent de sortir en public. Elle urine très souvent, mais en petites quantités. Elle n'a parfois pas le temps de se rendre à la toilette et mouille son pantalon. Elle n'a pas de brûlément mictionnel, ni de nycturie, ni hématurie. L'analyse et la culture d'urine sont normales. Quel traitement serait le plus approprié ?

- ☒ Cytoscopie et bilan urodynamique
- ☒ Oxibutinine
- ☒ Physiothérapie et rééducation péloenne
- ☒ Urinogèze par bandelette sous-urétrale

37

1 point
MCQ



Une femme de 54 ans, sans ménopausée depuis 3 ans, en couple stable depuis 5 ans, vous consulte au bureau pour douleur aux relations sexuelles. Ce problème devient de plus en plus inconfortable avec les années et semble avoir débuté environ 1 an après les dernières règles. Elle n'a pas de prurit vulvo-vaginal, ni de pertes vaginales anormales. Elle doit utiliser un lubrifiant, car elle trouve que son vagin est plutôt sec malgré une stimulation et un acte adéquats. À l'examen gynécologique, le vagin est rose pâle, on note une micro fissure au périnée après avoir écarté les lèvres pour insérer le spéculum, quelques pertes vaginales blanches, les muqueuses sont roses pâles et on note une absence de rugosité dans la muqueuse vaginale. Quel traitement lui proposez-vous ?

- ☒ Corticoïdes locaux topiques
- ☒ Créme atrofingue vulvaire et atrofingue par voie orale
- ☒ Estrogènes vaginaux
- ☒ Lubrifiants à base d'eau (B-15) et gel hydratant vaginal (Preparis)

38

1 point
MCQ



Une dame de 33 ans, qui a déjà eu une hystérectomie il y a 10 ans, se plaint de bouffées de chaleur intenses qui l'empêchent de dormir. Elle n'a pas d'autre antécédent particulier. Quel traitement est le plus approprié pour la soulager ?

- ☒ Combinaison d'œstrogène et de progestérone PO
- ☒ Oestrogène seulement PO
- ☒ Oestrogène topique vaginal
- ☒ Progestérone seulement PO

39

1 point
MCQ



Une dame de 50 ans vous consulte pour des bouffées de chaleur. Elle n'a pas de ménopausée depuis 15 mois. Elle ne souhaite vraiment pas prendre d'hormones, car se coustume à son cycle à son cycle. Par contre, elle est déçagée au travail avec la fréquence de ses chaleurs. Elle vous demande une alternative prouvée plus efficace que le placebo. Que lui suggérez-vous ?

- ☒ Acide à grappes noires (Ciméline)
- ☒ Graines de lin
- ☒ Huile de pépin de raisin
- ☒ Valériane

40

1 point
MCQ



Une femme de 25 ans se présente à l'urgence pour douleur pelvienne et fièvre. À l'examen gynécologique, vous notez une douleur à la mobilisation du col et un engorgement douloureux à l'entrée gauche. Aux examens laboratoires, les globules blancs et la proérite C-reactive sont augmentés. L'échographie pelvienne montre une lésion hétérogène de 5 cm à l'entrée gauche. Quel sera votre traitement initial ?

- ☒ Antibiotiques IV
- ☒ Antibiotiques PO
- ☒ Drainage guidé en radiologie
- ☒ Laparoscopie

41

1 point
MCQ



Vous avez fait l'examen pelvien et le test RNP d'une patiente de 30 ans ménopausée. Elle n'avait aucune plainte, ni aucun saignement. L'examen gynécologique était normal. Le résultat de la cytopologie cervicale revient : « Négatif ». Il n'y a pas de lésions épithéliales, ni de malignité. Il y a présence de cellules endométriales. Quelle sera la prochaine étape ?

- ☒ Biopsie de l'endométrium
- ☒ Contrôler le RNP dans 6 mois
- ☒ Faire un examen abdominal pelvien
- ☒ Pratiquer une hystéroscopie exploratoire

42

1 point
MCQ



Une patiente de 27 ans, à 14 semaines d'aménorrhée, consulte pour sa vésie post-coïtale au cabinet et vous rémander pas le cancer fœtal. Elle saigne depuis plusieurs jours. Sa hauteur utérine est à mi-chemin entre fœtal et la symphyse pubienne. Elle a des nausées et des vomissements très sévères. Quel suspectez-vous ?

- ☒ Léiomyome utérin
- ☒ Maladie trophoblastique gestationnelle
- ☒ Mort fœtale
- ☒ Polyhydramnios

43 1 point
M.C.A.



Une femme est enceinte de 37 semaines. Elle est suivie pour un diabète de type 1. Elle vient de faire un cardiogramme fœtal dont voici le résultat : 2 accélérations de 15 battements pendant 15 secondes notées en 40 minutes de tracé, bonne variabilité du cœur fœtal et absence de décélération. Quelle est la conduite appropriée ?

- ☒ Accouchement
- ☒ Profil biophysique
- ☒ Réassurance
- ☒ Reprendre le tracé du cœur fœtal pour 40 minutes

44 1 point
M.C.A.



Une femme de 38 ans en bonne santé vous consulte pour une première visite de grossesse. Ultrasonne confirme une grossesse vivante de 9 semaines. Elle est inquiète du risque de trisomie 21 lié à son âge. Que lui recommandez-vous ?

- ☒ Amniocentèse
- ☒ Biopsie chorionique
- ☒ Cordocentèse
- ☒ Dépistage sanguin combiné à la datation fœtale

45 1 point
M.C.A.



Une femme de 25 ans a eu une échographie endovaginale montrant une grossesse arrêtée à 8 semaines. Elle se présente aux urgences le lendemain de son échographie pour des pertes sanguines vaginales abondantes. Elle est étourdie. Sa tension artérielle est à 90/60 mmHg et sa FC à 110/min. À l'examen, le col est ouvert. Quel est la meilleure conduite ?

- ☒ Dilatation et curetage
- ☒ Expectative et observation
- ☒ Méthotrexate 50 mg en intramusculaire
- ☒ Misoprostol 200 mg par voie vaginale

46 1 point
M.C.A.



Une femme de 28 ans vous consulte pour 3 fausses couches consécutives. Ses trois dernières grossesses se sont terminées par des avortements spontanés au premier trimestre. Que recherchez-vous particulièrement au bilan génétique ?

- ☒ Anticorps antithrombotiques
- ☒ Déficit antithrombotique
- ☒ Facteur V de Leiden
- ☒ Mutation gène prothrombotique

47 1 point
M.C.A.

Une grossesse de 36 semaines d'aménorrhée, normale pour des données anténatales, fœtus en position transversaire environ 7,8 kg à 37 semaines depuis les dernières 24 heures. Le fœtus présente une FC de 100/min. Le tracé du cardiogramme fœtal est normal et démontre des contractions cardiaques régulières aux 10 minutes. L'échographie fœtale 328 semaines était normale. La présentation est céphalo-pelvienne et le placenta est à 30° et distal à 2 cm. Quelle est votre conduite ?

- ☒ Antécédents cardiovasculaires et fœtal
- ☒ Antécédents de sautes de régime fœtal
- ☒ Antécédents de sautes de régime fœtal
- ☒ Antécédents de sautes de régime fœtal

48 1 point
M.C.A.

Une femme multiparouse de 38 ans, sans traitement hormonal, consulte pour des règles hémorragiques et prolongées par où elle depuis 3 ans, mais consulte au moment pour un saignement léger d'une durée de 2 jours à 1 semaine dans les 2 semaines. Elle a une grossesse stable depuis 10 ans. Vous avez proposé à une femme de 38 semaines de grossesse qu'elle prenne un traitement hormonal. Une échographie effectuée est sans normalité. Sa grossesse fœtale par son médecin de famille il y a 4 mois est normale. L'inspection visuelle est normale. Quelle est la mesure la plus probable de son saignement ?

- ☒ Anomalie fœtale
- ☒ Anomalie de l'ovulation
- ☒ Anomalie de l'ovulation
- ☒ Anomalie de l'ovulation

49 1 point
M.C.A.

Une patiente de 27 ans consulte pour une tumeur depuis quelques semaines. Elle a noté des pertes sanguinolentes sur ses grandes lèvres. Elle n'a pas de symptômes différents dans la dernière année et la tumeur ne gêne pas la sexualité. À l'examen clinique, nous nous des tumeurs nodulaires rouges et tendres sur les grandes et petites lèvres.



Quelle est la mesure la plus probable ?

- ☒ Biopsie histologique de la tumeur
- ☒ Résection par voie chirurgicale des tumeurs vulvaires
- ☒ Résection par voie chirurgicale des tumeurs vulvaires
- ☒ Méthotrexate par voie intraveineuse

50 1 point
M.C.A.

Une femme de 28 ans vous consulte pour une tumeur. Elle a noté à l'origine 1 x 2 cm, puis 3 cm, puis 4 cm, puis 5 cm, puis 6 cm, puis 7 cm, puis 8 cm, puis 9 cm, puis 10 cm, puis 11 cm, puis 12 cm, puis 13 cm, puis 14 cm, puis 15 cm, puis 16 cm, puis 17 cm, puis 18 cm, puis 19 cm, puis 20 cm, puis 21 cm, puis 22 cm, puis 23 cm, puis 24 cm, puis 25 cm, puis 26 cm, puis 27 cm, puis 28 cm, puis 29 cm, puis 30 cm, puis 31 cm, puis 32 cm, puis 33 cm, puis 34 cm, puis 35 cm, puis 36 cm, puis 37 cm, puis 38 cm, puis 39 cm, puis 40 cm, puis 41 cm, puis 42 cm, puis 43 cm, puis 44 cm, puis 45 cm, puis 46 cm, puis 47 cm, puis 48 cm, puis 49 cm, puis 50 cm, puis 51 cm, puis 52 cm, puis 53 cm, puis 54 cm, puis 55 cm, puis 56 cm, puis 57 cm, puis 58 cm, puis 59 cm, puis 60 cm, puis 61 cm, puis 62 cm, puis 63 cm, puis 64 cm, puis 65 cm, puis 66 cm, puis 67 cm, puis 68 cm, puis 69 cm, puis 70 cm, puis 71 cm, puis 72 cm, puis 73 cm, puis 74 cm, puis 75 cm, puis 76 cm, puis 77 cm, puis 78 cm, puis 79 cm, puis 80 cm, puis 81 cm, puis 82 cm, puis 83 cm, puis 84 cm, puis 85 cm, puis 86 cm, puis 87 cm, puis 88 cm, puis 89 cm, puis 90 cm, puis 91 cm, puis 92 cm, puis 93 cm, puis 94 cm, puis 95 cm, puis 96 cm, puis 97 cm, puis 98 cm, puis 99 cm, puis 100 cm, puis 101 cm, puis 102 cm, puis 103 cm, puis 104 cm, puis 105 cm, puis 106 cm, puis 107 cm, puis 108 cm, puis 109 cm, puis 110 cm, puis 111 cm, puis 112 cm, puis 113 cm, puis 114 cm, puis 115 cm, puis 116 cm, puis 117 cm, puis 118 cm, puis 119 cm, puis 120 cm, puis 121 cm, puis 122 cm, puis 123 cm, puis 124 cm, puis 125 cm, puis 126 cm, puis 127 cm, puis 128 cm, puis 129 cm, puis 130 cm, puis 131 cm, puis 132 cm, puis 133 cm, puis 134 cm, puis 135 cm, puis 136 cm, puis 137 cm, puis 138 cm, puis 139 cm, puis 140 cm, puis 141 cm, puis 142 cm, puis 143 cm, puis 144 cm, puis 145 cm, puis 146 cm, puis 147 cm, puis 148 cm, puis 149 cm, puis 150 cm, puis 151 cm, puis 152 cm, puis 153 cm, puis 154 cm, puis 155 cm, puis 156 cm, puis 157 cm, puis 158 cm, puis 159 cm, puis 160 cm, puis 161 cm, puis 162 cm, puis 163 cm, puis 164 cm, puis 165 cm, puis 166 cm, puis 167 cm, puis 168 cm, puis 169 cm, puis 170 cm, puis 171 cm, puis 172 cm, puis 173 cm, puis 174 cm, puis 175 cm, puis 176 cm, puis 177 cm, puis 178 cm, puis 179 cm, puis 180 cm, puis 181 cm, puis 182 cm, puis 183 cm, puis 184 cm, puis 185 cm, puis 186 cm, puis 187 cm, puis 188 cm, puis 189 cm, puis 190 cm, puis 191 cm, puis 192 cm, puis 193 cm, puis 194 cm, puis 195 cm, puis 196 cm, puis 197 cm, puis 198 cm, puis 199 cm, puis 200 cm, puis 201 cm, puis 202 cm, puis 203 cm, puis 204 cm, puis 205 cm, puis 206 cm, puis 207 cm, puis 208 cm, puis 209 cm, puis 210 cm, puis 211 cm, puis 212 cm, puis 213 cm, puis 214 cm, puis 215 cm, puis 216 cm, puis 217 cm, puis 218 cm, puis 219 cm, puis 220 cm, puis 221 cm, puis 222 cm, puis 223 cm, puis 224 cm, puis 225 cm, puis 226 cm, puis 227 cm, puis 228 cm, puis 229 cm, puis 230 cm, puis 231 cm, puis 232 cm, puis 233 cm, puis 234 cm, puis 235 cm, puis 236 cm, puis 237 cm, puis 238 cm, puis 239 cm, puis 240 cm, puis 241 cm, puis 242 cm, puis 243 cm, puis 244 cm, puis 245 cm, puis 246 cm, puis 247 cm, puis 248 cm, puis 249 cm, puis 250 cm, puis 251 cm, puis 252 cm, puis 253 cm, puis 254 cm, puis 255 cm, puis 256 cm, puis 257 cm, puis 258 cm, puis 259 cm, puis 260 cm, puis 261 cm, puis 262 cm, puis 263 cm, puis 264 cm, puis 265 cm, puis 266 cm, puis 267 cm, puis 268 cm, puis 269 cm, puis 270 cm, puis 271 cm, puis 272 cm, puis 273 cm, puis 274 cm, puis 275 cm, puis 276 cm, puis 277 cm, puis 278 cm, puis 279 cm, puis 280 cm, puis 281 cm, puis 282 cm, puis 283 cm, puis 284 cm, puis 285 cm, puis 286 cm, puis 287 cm, puis 288 cm, puis 289 cm, puis 290 cm, puis 291 cm, puis 292 cm, puis 293 cm, puis 294 cm, puis 295 cm, puis 296 cm, puis 297 cm, puis 298 cm, puis 299 cm, puis 300 cm, puis 301 cm, puis 302 cm, puis 303 cm, puis 304 cm, puis 305 cm, puis 306 cm, puis 307 cm, puis 308 cm, puis 309 cm, puis 310 cm, puis 311 cm, puis 312 cm, puis 313 cm, puis 314 cm, puis 315 cm, puis 316 cm, puis 317 cm, puis 318 cm, puis 319 cm, puis 320 cm, puis 321 cm, puis 322 cm, puis 323 cm, puis 324 cm, puis 325 cm, puis 326 cm, puis 327 cm, puis 328 cm, puis 329 cm, puis 330 cm, puis 331 cm, puis 332 cm, puis 333 cm, puis 334 cm, puis 335 cm, puis 336 cm, puis 337 cm, puis 338 cm, puis 339 cm, puis 340 cm, puis 341 cm, puis 342 cm, puis 343 cm, puis 344 cm, puis 345 cm, puis 346 cm, puis 347 cm, puis 348 cm, puis 349 cm, puis 350 cm, puis 351 cm, puis 352 cm, puis 353 cm, puis 354 cm, puis 355 cm, puis 356 cm, puis 357 cm, puis 358 cm, puis 359 cm, puis 360 cm, puis 361 cm, puis 362 cm, puis 363 cm, puis 364 cm, puis 365 cm, puis 366 cm, puis 367 cm, puis 368 cm, puis 369 cm, puis 370 cm, puis 371 cm, puis 372 cm, puis 373 cm, puis 374 cm, puis 375 cm, puis 376 cm, puis 377 cm, puis 378 cm, puis 379 cm, puis 380 cm, puis 381 cm, puis 382 cm, puis 383 cm, puis 384 cm, puis 385 cm, puis 386 cm, puis 387 cm, puis 388 cm, puis 389 cm, puis 390 cm, puis 391 cm, puis 392 cm, puis 393 cm, puis 394 cm, puis 395 cm, puis 396 cm, puis 397 cm, puis 398 cm, puis 399 cm, puis 400 cm, puis 401 cm, puis 402 cm, puis 403 cm, puis 404 cm, puis 405 cm, puis 406 cm, puis 407 cm, puis 408 cm, puis 409 cm, puis 410 cm, puis 411 cm, puis 412 cm, puis 413 cm, puis 414 cm, puis 415 cm, puis 416 cm, puis 417 cm, puis 418 cm, puis 419 cm, puis 420 cm, puis 421 cm, puis 422 cm, puis 423 cm, puis 424 cm, puis 425 cm, puis 426 cm, puis 427 cm, puis 428 cm, puis 429 cm, puis 430 cm, puis 431 cm, puis 432 cm, puis 433 cm, puis 434 cm, puis 435 cm, puis 436 cm, puis 437 cm, puis 438 cm, puis 439 cm, puis 440 cm, puis 441 cm, puis 442 cm, puis 443 cm, puis 444 cm, puis 445 cm, puis 446 cm, puis 447 cm, puis 448 cm, puis 449 cm, puis 450 cm, puis 451 cm, puis 452 cm, puis 453 cm, puis 454 cm, puis 455 cm, puis 456 cm, puis 457 cm, puis 458 cm, puis 459 cm, puis 460 cm, puis 461 cm, puis 462 cm, puis 463 cm, puis 464 cm, puis 465 cm, puis 466 cm, puis 467 cm, puis 468 cm, puis 469 cm, puis 470 cm, puis 471 cm, puis 472 cm, puis 473 cm, puis 474 cm, puis 475 cm, puis 476 cm, puis 477 cm, puis 478 cm, puis 479 cm, puis 480 cm, puis 481 cm, puis 482 cm, puis 483 cm, puis 484 cm, puis 485 cm, puis 486 cm, puis 487 cm, puis 488 cm, puis 489 cm, puis 490 cm, puis 491 cm, puis 492 cm, puis 493 cm, puis 494 cm, puis 495 cm, puis 496 cm, puis 497 cm, puis 498 cm, puis 499 cm, puis 500 cm, puis 501 cm, puis 502 cm, puis 503 cm, puis 504 cm, puis 505 cm, puis 506 cm, puis 507 cm, puis 508 cm, puis 509 cm, puis 510 cm, puis 511 cm, puis 512 cm, puis 513 cm, puis 514 cm, puis 515 cm, puis 516 cm, puis 517 cm, puis 518 cm, puis 519 cm, puis 520 cm, puis 521 cm, puis 522 cm, puis 523 cm, puis 524 cm, puis 525 cm, puis 526 cm, puis 527 cm, puis 528 cm, puis 529 cm, puis 530 cm, puis 531 cm, puis 532 cm, puis 533 cm, puis 534 cm, puis 535 cm, puis 536 cm, puis 537 cm, puis 538 cm, puis 539 cm, puis 540 cm, puis 541 cm, puis 542 cm, puis 543 cm, puis 544 cm, puis 545 cm, puis 546 cm, puis 547 cm, puis 548 cm, puis 549 cm, puis 550 cm, puis 551 cm, puis 552 cm, puis 553 cm, puis 554 cm, puis 555 cm, puis 556 cm, puis 557 cm, puis 558 cm, puis 559 cm, puis 560 cm, puis 561 cm, puis 562 cm, puis 563 cm, puis 564 cm, puis 565 cm, puis 566 cm, puis 567 cm, puis 568 cm, puis 569 cm, puis 570 cm, puis 571 cm, puis 572 cm, puis 573 cm, puis 574 cm, puis 575 cm, puis 576 cm, puis 577 cm, puis 578 cm, puis 579 cm, puis 580 cm, puis 581 cm, puis 582 cm, puis 583 cm, puis 584 cm, puis 585 cm, puis 586 cm, puis 587 cm, puis 588 cm, puis 589 cm, puis 590 cm, puis 591 cm, puis 592 cm, puis 593 cm, puis 594 cm, puis 595 cm, puis 596 cm, puis 597 cm, puis 598 cm, puis 599 cm, puis 600 cm, puis 601 cm, puis 602 cm, puis 603 cm, puis 604 cm, puis 605 cm, puis 606 cm, puis 607 cm, puis 608 cm, puis 609 cm, puis 610 cm, puis 611 cm, puis 612 cm, puis 613 cm, puis 614 cm, puis 615 cm, puis 616 cm, puis 617 cm, puis 618 cm, puis 619 cm, puis 620 cm, puis 621 cm, puis 622 cm, puis 623 cm, puis 624 cm, puis 625 cm, puis 626 cm, puis 627 cm, puis 628 cm, puis 629 cm, puis 630 cm, puis 631 cm, puis 632 cm, puis 633 cm, puis 634 cm, puis 635 cm, puis 636 cm, puis 637 cm, puis 638 cm, puis 639 cm, puis 640 cm, puis 641 cm, puis 642 cm, puis 643 cm, puis 644 cm, puis 645 cm, puis 646 cm, puis 647 cm, puis 648 cm, puis 649 cm, puis 650 cm, puis 651 cm, puis 652 cm, puis 653 cm, puis 654 cm, puis 655 cm, puis 656 cm, puis 657 cm, puis 658 cm, puis 659 cm, puis 660 cm, puis 661 cm, puis 662 cm, puis 663 cm, puis 664 cm, puis 665 cm, puis 666 cm, puis 667 cm, puis 668 cm, puis 669 cm, puis 670 cm, puis 671 cm, puis 672 cm, puis 673 cm, puis 674 cm, puis 675 cm, puis 676 cm, puis 677 cm, puis 678 cm, puis 679 cm, puis 680 cm, puis 681 cm, puis 682 cm, puis 683 cm, puis 684 cm, puis 685 cm, puis 686 cm, puis 687 cm, puis 688 cm, puis 689 cm, puis 690 cm, puis 691 cm, puis 692 cm, puis 693 cm, puis 694 cm, puis 695 cm, puis 696 cm, puis 697 cm, puis 698 cm, puis 699 cm, puis 700 cm, puis 701 cm, puis 702 cm, puis 703 cm, puis 704 cm, puis 705 cm, puis 706 cm, puis 707 cm, puis 708 cm, puis 709 cm, puis 710 cm, puis 711 cm, puis 712 cm, puis 713 cm, puis 714 cm, puis 715 cm, puis 716 cm, puis 717 cm, puis 718 cm, puis 719 cm, puis 720 cm, puis 721 cm, puis 722 cm, puis 723 cm, puis 724 cm, puis 725 cm, puis 726 cm, puis 727 cm, puis 728 cm, puis 729 cm, puis 730 cm, puis 731 cm, puis 732 cm, puis 733 cm, puis 734 cm, puis 735 cm, puis 736 cm, puis 737 cm, puis 738 cm, puis 739 cm, puis 740 cm, puis 741 cm, puis 742 cm, puis 743 cm, puis 744 cm, puis 745 cm, puis 746 cm, puis 747 cm, puis 748 cm, puis 749 cm, puis 750 cm, puis 751 cm, puis 752 cm, puis 753 cm, puis 754 cm, puis 755 cm, puis 756 cm, puis 757 cm, puis 758 cm, puis 759 cm, puis 760 cm, puis 761 cm, puis 762 cm, puis 763 cm, puis 764 cm, puis 765 cm, puis 766 cm, puis 767 cm, puis 768 cm, puis 769 cm, puis 770 cm, puis 771 cm, puis 772 cm, puis 773 cm, puis 774 cm, puis 775 cm, puis 776 cm, puis 777 cm, puis 778 cm, puis 779 cm, puis 780 cm, puis 781 cm, puis 782 cm, puis 783 cm, puis 784 cm, puis 785 cm, puis 786 cm, puis 787 cm, puis 788 cm, puis 789 cm, puis 790 cm, puis 791 cm, puis 792 cm, puis 793 cm, puis 794 cm, puis 795 cm, puis 796 cm, puis 797 cm, puis 798 cm, puis 799 cm, puis 800 cm, puis 801 cm, puis 802 cm, puis 803 cm, puis 804 cm, puis 805 cm, puis 806 cm, puis 807 cm, puis 808 cm, puis 809 cm, puis 810 cm, puis 811 cm, puis 812 cm, puis 813 cm, puis 814 cm, puis 815 cm, puis 816 cm, puis 817 cm, puis 818 cm, puis 819 cm, puis 820 cm, puis 821 cm, puis 822 cm, puis 823 cm, puis 824 cm, puis 825 cm, puis 826 cm, puis 827 cm, puis 828 cm, puis 829 cm, puis 830 cm, puis 831 cm, puis 832 cm, puis 833 cm, puis 834 cm, puis 835 cm, puis 836 cm, puis 837 cm, puis 838 cm, puis 839 cm, puis 840 cm, puis 841 cm, puis 842 cm, puis 843 cm, puis 844 cm, puis 845 cm, puis 846 cm, puis 847 cm, puis 848 cm, puis 849 cm, puis 850 cm, puis 851 cm, puis 852 cm, puis 853 cm, puis 854 cm, puis 855 cm, puis 856 cm, puis 857 cm, puis 858 cm, puis 859 cm, puis 860 cm, puis 861 cm, puis 862 cm, puis 863 cm, puis 864 cm, puis 865 cm, puis 866 cm, puis 867 cm, puis 868 cm, puis 869 cm, puis 870 cm, puis 871 cm, puis 872 cm, puis 873 cm, puis 874 cm, puis 875 cm, puis 876 cm, puis 877 cm, puis 878 cm, puis 879 cm, puis 880 cm, puis 881 cm, puis 882 cm, puis 883 cm, puis 884 cm, puis 885 cm, puis 886 cm, puis 887 cm, puis 888 cm, puis 889 cm, puis 890 cm, puis 891 cm, puis 892 cm, puis 893 cm, puis 894 cm, puis 895 cm, puis 896 cm, puis 897 cm, puis 898 cm, puis 899 cm, puis 900 cm, puis 901 cm, puis 902 cm, puis 903 cm, puis 904 cm, puis 905 cm, puis 906 cm, puis 907 cm, puis 908 cm, puis 909 cm, puis 910 cm, puis 911 cm, puis 912 cm, puis 913 cm, puis 914 cm, puis 915 cm, puis 916 cm, puis 917 cm, puis 918 cm, puis 919 cm, puis 920 cm, puis 921 cm, puis 922 cm, puis 923 cm, puis 924 cm, puis 925 cm, puis 926 cm, puis 927 cm, puis 928 cm, puis 929 cm, puis 930 cm, puis 931 cm, puis 932 cm, puis 933 cm, puis 934 cm, puis 935 cm, puis 936 cm, puis 937 cm, puis 938 cm, puis 939 cm, puis 940 cm, puis 941 cm, puis 942 cm, puis 943 cm, puis 944 cm, puis 945 cm, puis 946 cm, puis 947 cm, puis 948 cm, puis 949 cm, puis 950 cm, puis 951 cm, puis 952 cm, puis 953 cm, puis 954 cm, puis 955 cm, puis 956 cm, puis 957 cm, puis 958 cm, puis 959 cm, puis 960 cm, puis 961 cm, puis 962 cm, puis 963 cm, puis 964 cm, puis 965 cm, puis 966 cm, puis 967 cm, puis 968 cm, puis 969 cm, puis 970 cm, puis 971 cm, puis 972 cm, puis 973 cm, puis 974 cm, puis 975 cm, puis 976 cm, puis 977 cm, puis 978 cm, puis 979 cm, puis 980 cm, puis 981 cm, puis 982 cm, puis 983 cm, puis 984 cm, puis 985 cm, puis 986 cm, puis 987 cm, puis 988 cm, puis 989 cm, puis 990 cm, puis 991 cm, puis 992 cm, puis 993 cm, puis 994 cm, puis 995 cm, puis 996 cm, puis 997 cm, puis 998 cm, puis 999 cm, puis 1000 cm, puis 1001 cm, puis 1002 cm, puis 1003 cm, puis 1004 cm, puis 1005 cm, puis 1006 cm, puis 1007 cm, puis 1008 cm, puis 1009 cm, puis 1010 cm, puis 1011 cm, puis 1012 cm, puis 1013 cm, puis 1014 cm, puis 1015 cm, puis 1016 cm, puis 1017 cm, puis 1018 cm, puis 1019 cm, puis 1020 cm, puis 1021 cm, puis 1022 cm, puis 1023 cm, puis 1024 cm, puis 1025 cm, puis 1026 cm, puis 1027 cm, puis 1028 cm, puis 1029 cm, puis 1030 cm, puis 1031 cm, puis 1032 cm, puis 1033 cm, puis 1034 cm, puis 1035 cm, puis 1036 cm, puis 1037 cm, puis 1038 cm, puis 1039 cm, puis 1040 cm, puis 1041 cm, puis 1042 cm, puis 1043 cm, puis 1044 cm, puis 1045 cm, puis 1046 cm, puis 1047 cm, puis 1048 cm, puis 1049 cm, puis 1050 cm, puis 1051 cm, puis 1052 cm, puis 1053 cm, puis 1054 cm, puis 1055 cm, puis 1056 cm, puis 1057 cm, puis 1058 cm, puis 1059 cm, puis 1060 cm, puis 1061 cm, puis 1062 cm, puis 1063 cm, puis 1064 cm, puis 1065 cm, puis 1066 cm, puis 1067 cm, puis 1068 cm, puis 1069 cm, puis 1070 cm, puis 1071 cm, puis 1072 cm, puis 1073 cm, puis 1074 cm, puis 1075 cm, puis 1076 cm, puis 1077 cm, puis 1078 cm, puis 1079 cm, puis 1080 cm, puis 1081 cm, puis 1082 cm, puis 1083 cm, puis 1084 cm, puis 1085 cm, puis 1086 cm, puis 1087 cm, puis 1088 cm, puis 1089 cm, puis 1090 cm, puis 1091 cm, puis 1092 cm, puis 1093 cm, puis 1094 cm, puis 1095 cm, puis 1096 cm, puis 1097 cm, puis 1098 cm, puis 1099 cm, puis 1100 cm, puis 1101 cm, puis 1102 cm, puis 1103 cm, puis 1104 cm, puis 1105 cm, puis 1106 cm, puis 1107 cm, puis 1108 cm, puis 1109 cm, puis 1110 cm, puis 1111 cm, puis 1112 cm, puis 1113 cm, puis 1114 cm, puis 1115 cm, puis 1116 cm, puis 1117 cm, puis 1118 cm, puis 1119 cm, puis 1120 cm, puis 1121 cm, puis 1122 cm, puis 1123 cm, puis 1124 cm, puis 1125 cm, puis 1126 cm, puis 1127 cm, puis 1128 cm, puis 1129 cm, puis 1130 cm, puis 1131 cm, puis 1132 cm, puis 1133 cm, puis 1134 cm, puis 1135 cm, puis 1136 cm, puis 1137 cm, puis 1138 cm, puis 1139 cm, puis 1140 cm, puis 1141 cm, puis 1142 cm, puis 1143 cm, puis 1144 cm, puis 1145 cm, puis 1146 cm, puis 1147 cm, puis 1148 cm, puis 1149 cm, puis 1150 cm, puis 1151 cm, puis 1152 cm, puis 1153 cm, puis 1154 cm, puis 1155 cm, puis 1156 cm, puis 1157 cm, puis 1158 cm, puis 1159 cm, puis 1160 cm, puis 1161 cm, puis 1162 cm, puis 1163 cm, puis 1164 cm, puis 1165 cm, puis 1166 cm, puis 1167 cm, puis 1168 cm, puis 1169 cm, puis 1170 cm, puis 1171 cm, puis 1172 cm, puis 1173 cm, puis 1174 cm, puis 1175 cm, puis 1176 cm, puis 1177 cm, puis 1178 cm, puis 1179 cm, puis 1180 cm, puis 1181 cm, puis 1182 cm, puis 1183 cm, puis 1184 cm, puis 1185 cm, puis 1186 cm, puis 1187 cm, puis 1188 cm, puis 1189 cm, puis 1190 cm, puis 1191 cm, puis 1192 cm, puis 1193 cm, puis 1194 cm, puis 1195 cm, puis 1196 cm, puis 1197 cm, puis 1198 cm, puis 1199 cm, puis 1200 cm, puis 1201 cm, puis 1202 cm, puis 1203 cm, puis 1204 cm, puis 1205 cm, puis 1206 cm, puis 1207 cm, puis 1208 cm, puis 1209 cm, puis 1210 cm, puis 1211 cm, puis 1212 cm, puis 1213 cm, puis 1214 cm, puis 1215 cm, puis 1216 cm, puis 1217 cm, puis 1218 cm, puis 1219 cm, puis 1220 cm, puis 1221 cm, puis 1222 cm, puis 1223 cm, puis 1224 cm, puis 1225 cm, puis 1226 cm, puis 1227 cm, puis 1228 cm, puis 1229 cm, puis 1230 cm, puis 1231 cm, puis 1232 cm, puis 1233 cm, puis 1234 cm, puis 1235 cm, puis 1236 cm, puis 1237 cm, puis 1238 cm, puis 1239 cm, puis 1240 cm, puis 1241 cm, puis 1242 cm, puis 1243 cm, puis 1244 cm, puis 1245 cm, puis 1246 cm, puis 1247 cm, puis 1248 cm, puis 1249 cm, puis 1250 cm, puis 1251 cm, puis 1252 cm, puis 1253 cm, puis 1254 cm, puis 1255 cm, puis 1256 cm, puis 1257 cm, puis 1258 cm, puis 1259 cm, puis 1260 cm, puis 1261 cm, puis 1262 cm, puis 1263 cm, puis 1264 cm, puis 1265 cm, puis 1266 cm, puis 1267 cm, puis 1268 cm, puis 1269 cm, puis 1270 cm, puis 1271 cm, puis 1272 cm, puis 1273 cm, puis 1274 cm, puis 1275 cm, puis 1276 cm, puis 1277 cm, puis 1278 cm, puis 1279 cm, puis 1280 cm, puis 1281 cm, puis 1282 cm, puis 1283 cm, puis 1284 cm, puis 1285 cm, puis 1286 cm, puis 1287 cm, puis 1288 cm, puis 1289 cm, puis 1290 cm, puis 1291 cm, puis 1292 cm, puis 1293 cm, puis 1294 cm, puis 1295 cm, puis 1296 cm, puis 1297 cm, puis 1298 cm, puis 1299 cm, puis 1300 cm, puis 1301 cm, puis 1302 cm, puis 1303 cm, puis 1304 cm, puis 1305 cm, puis 1306 cm, puis 1307 cm, puis 1308 cm, puis 1309 cm, puis 1310 cm, puis 1311 cm, puis 1312 cm, puis 1313 cm, puis 1314 cm, puis 1315 cm, puis 1316 cm, puis 1317 cm, puis 1318 cm, puis 1319 cm, puis 1320 cm, puis 1321 cm, puis 1322 cm, puis 1323 cm, puis 1324 cm, puis 1325 cm, puis 1326 cm, puis 1327 cm, puis 1328 cm, puis 1329 cm, puis 1330 cm, puis 1331 cm, puis 1332 cm, puis 1333 cm, puis 1334 cm, puis 1335 cm, puis 1336 cm, puis 1337 cm, puis 1338 cm, puis 1339 cm, puis 1340 cm, puis 1341 cm, puis 1342 cm, puis 1343 cm, puis 1344 cm, puis 1345 cm, puis 1346 cm, puis 1347 cm, puis 1348 cm, puis 1349 cm, puis 1350 cm, puis 1351 cm, puis 1352 cm, puis 1353 cm, puis 1354 cm, puis 1355 cm, puis 1356 cm, puis 1357 cm, puis 1358 cm, puis 1359 cm, puis 1360 cm, puis 1361 cm, puis 1362 cm, puis 1363 cm, puis 1364 cm, puis 1365 cm, puis 1366 cm, puis 1367 cm, puis 1368 cm, puis 1369 cm, puis 1370 cm, puis 1371 cm, puis 1372 cm, puis 1373 cm, puis 1374 cm, puis 1375 cm, puis 1376 cm, puis 1377 cm, puis 1378 cm, puis 1379 cm, puis 1380 cm, puis 1381 cm, puis 1382 cm, puis 1383 cm, puis 1384 cm, puis 1385 cm, puis 1386 cm, puis 1387 cm, puis 1388 cm, puis 1389 cm, puis 1390 cm, puis 1391 cm, puis 1392 cm

51 1 point
0/1



Une femme de 45 ans, G2, se présente à l'urgence pour une métrorragie qui est survenue après 8 mois d'aménorrhée et qui dure depuis 13 jours. Elle a des cycles menstruels très longs depuis sa ménarche, soit aux 3 à 6 mois. Elle a un partenaire sexuel stable et elle est ligaturée. Elle est obèse avec un IMC à 38. Elle est frivole et présente de l'œdème au visage et au dos. Les signes vitaux sont normaux. L'obuse est de volume normal à l'examen bi-manuel. Quelle est votre conduite ?

- ☒ Bilan de l'endométrio
- ☒ Echographie pelvienne
- ☒ Obésité et surpoids sévère
- ☒ Hystéroscopie

52 1 point
0/1



Une patiente primipare de 30 ans, à 23 semaines semaines d'aménorrhée, présente sur l'échographie morphologique du 2^{ème} trimestre, un retard de croissance intra utérin sévère avec un fœtus au 3e percentile pour tous ses paramètres soit la tête, l'abdomen et le fœtus. Quelle cause est la plus probable ?

- ☒ Anomalie chromosomique fœtale
- ☐ Dystrophie placentaire
- ☒ Maladie hypertensive de la grossesse
- ☒ Malnutrition de la mère

53 1 point
0/1



Vous voyez une femme de 30 ans pour sa visite de contrôle à 36 semaines d'aménorrhée. Elle n'a aucune plainte. Sa TA est à 110/80. Le cœur fœtal est à 140/min et la hauteur utérine est mesurée à 28 cm. Vous demandez une échographie obstétricale, dont voici les résultats :

poids fœtal estimé : 3^{ème} percentile
 périmètre abdominal : 3^{ème} percentile
 périmètre crânien : 7^{ème} percentile
 fœtus : 3^{ème} percentile
 volume de liquide amniotique : normal
 profil biophysique à 36 :
 danger de l'artère umbilicale : normal

Quelle est la conduite appropriée ?

- ☒ Césarienne en urgence
- ☒ Césarienne
- ☒ Réalisation d'une hygie<pre>ne</pre> précoce par voie orale
- ☒ Enregistrement du rythme cardiaque fœtal

54 1 point
0/1



Une femme de 22 ans présente des démangeaisons à la vulve depuis 3 jours et elle a des lésions plus abondantes, blanches et épaisses que vous observez à l'examen. Cela lui occasionne aussi parfois des brûlures lors de la miction. Quel traitement lui recommandez vous ?

- ☒ Antibiotique topique
- ☐ Antibiotique PO
- ☒ Baie de sélag
- ☒ Crème antifongique

55 1 point
0/1



Les résultats d'un essai clinique randomisé visent à évaluer l'efficacité d'un essai de carbédge comparativement à un placebo sur le risque d'infection urinaire. 500 femmes présentant des infections urinaires à répétition ont été réparties aléatoirement dans l'un des 2 groupes. Après une période de suivi de 24 mois, 20 patientes ont présenté au moins une infection urinaire dans le groupe « carbédge » et 30 patientes dans le groupe « placebo ». Calculer la réduction de risque absolu, exprimé par nombre de patientes par groupe, du risque étudié.

- ☒ 2%
- ☒ 10%
- ☒ 16,7%
- ☒ 20%

56 1 point
0/1



Un fumeur de 58 ans se présente à votre bureau pour une première visite. Il est asystolotique. Il n'a pas d'antécédents médicaux personnels, ni familial particulier et ne prend pas de médicaments. Il est fumeur 50 paquets annuels et prend en moyenne 3 consommations d'alcool par jour. Que lui recommandez vous ?

- ☒ Dosage de la TSH
- ☒ Echographie abdominale
- ☒ Radiographie des poumons
- ☒ Recherche de sang dans les selles

57 1 point
0/1



En considérant que la prévalence du cancer du sein chez une clientèle particulière est de 20% et que la mammographie a une sensibilité de 95% avec une spécificité de 90%, quelle est la valeur prédictive positive de la mammographie ?

- ☒ 55%
- ☒ 70%
- ☒ 90%
- ☒ 95%

58 1 point



Vous réalisez une étude de cohorte pour examiner l'association entre l'exposition aux poussières minérales et les atteintes pulmonaires, mesurées par spirométrie. Sachant que la capacité pulmonaire normale diminue avec l'âge, vous vous inquiétez d'obtenir lors de l'analyse des résultats que la moyenne d'âge chez les individus exposés aux poussières minérales est moins élevée que chez les individus non exposés. Vous suspectez un biais. Si ce biais existe, quel sera son effet sur la mesure d'association calculée pour évaluer l'impact de l'exposition aux poussières sur la capacité pulmonaire ?

- ☒ Aucun effet
- ☒ Sous-estimation
- ☒ Surestimation
- ☒ Impossible à estimer

59 1 point



Chez les hommes de moins de 50 ans, la concentration sanguine de l'enzyme protéolyse spécifique (DPS) est considérée comme anormale si elle excède le seuil de 2,5 µg/L. Quel serait l'impact d'une modification de ce seuil à 5,0 µg/L sur la spécificité ?

- ☒ Augmentation
- ☒ Diminution
- ☒ Pas de changement
- ☒ Impossible à déterminer

60 1 point



Un essai clinique randomisé a été effectué visant à évaluer l'efficacité du cancérofile comparativement à un placebo sur la prévention du cancer du sein. 5000 femmes à risque élevé de cancer du sein ont été réparties aléatoirement dans l'un des 2 groupes : cancérofile « ou » placebo ». Voici les résultats : après un suivi médian de 8 ans, 250 femmes ont développé un cancer du sein dans le groupe « cancérofile » et 300 femmes dans le groupe « placebo ». Calculez le risque relatif, si les pertes de suivi sont les mêmes dans les deux groupes.

- ☒ 0,12
- ☒ 0,8
- ☒ 1,2
- ☒ Impossible à calculer

61 1 point



Vous analysez un article décrivant l'efficacité d'un nouveau bisphosphonate (inhibiteur de la résorption osseuse) à celle du bisphosphonate recommandé par les lignes directrices actuelles. Parmi les critères de jugement suivants, quel est celui qui pourrait vous amener à recommander ce nouveau bisphosphonate plutôt que l'ancien, considérant que ces deux médicaments ont le même profil d'effets secondaires ?

- ☒ Densité minérale osseuse lombaire : différence de 26 en faveur du nouveau médicament ($p < 0,001$)
- ☒ Densité minérale osseuse fémorale : différence de 6% en faveur du nouveau médicament ($p = 0,05$)
- ☒ Fracture de la hanche : différence de 20% en faveur du nouveau bisphosphonate ($p = 0,002$)
- ☒ Marqueurs sanguins de la résorption osseuse : différence de 22 % en faveur du nouveau bisphosphonate ($p < 0,001$)

62 1 point



Chez un groupe de femmes avec une prévalence de cancer du sein de 1%, la mammographie a une sensibilité de 90% et une spécificité de 95% avec une valeur prédictive positive de 70%. Pour un autre groupe de femmes, si la prévalence du cancer du sein est de 10%, quelle sera la conséquence sur la valeur prédictive positive ?

- ☒ Augmentée
- ☒ Diminuée
- ☒ Inchangée
- ☒ Impossible à déterminer

63 1 point



Envis le 8 janvier et le 30 mars 2015, 12 cas de rougeole ont été rapportés. Pour l'instant, il n'y a pas de cas sporadiques parmi lesquels l'absence de la maladie lors d'un séjour à l'étranger. Chez à partir du mois d'octobre que s'installe une transmission locale. En date du 2 novembre 2015 (12-02), 753 cas de rougeole ont été signalés alors qu'au même moment l'année dernière, on comptait 4 cas ; un rapport en moyenne 22 semaines au cours des 5 dernières années. On compte plus de 176 de cas hospitalisés, mais aucun décès n'a été enregistré à ce jour. Comment peut-on affirmer l'existence d'une épidémie ?

- ☒ Augmentation du nombre de cas à un niveau plus élevé que celui qui est attendu
- ☒ Augmentation du taux de létalité supérieur à ce qui était connu dans le passé
- ☒ Période de latence où on s'attend à un grand nombre de cas
- ☒ Présence d'au moins deux fois plus de cas qu'à la période précédente

64 1 point



Un travailleur de 20 ans présente de la dyspnée importante et des sibilances audibles, le plus souvent après ses heures de travail. Il n'est pas symptomatique pendant ses vacances. À l'examen physique, on note des signes vitaux normaux, un temps expiratoire prolongé et des sibilances en fin d'expiration. Un test de fonction respiratoire démontre une oblitération du VEMS post-méthacholine. Laquelle de ces substances est le plus probablement en cause ?

- ☒ Amiante
- ☒ Bétailum
- ☒ Particules de bois
- ☒ Silice

65 1 point



Une étude a été réalisée parmi les travailleurs d'une mine canadienne d'uranium. Les dossiers de tous les mineurs âgés de 40 à 50 ans qui étaient affectés aux activités d'extraction souterraine en date du 1^{er} janvier 1990 ont été revus. La survenue d'un cancer du poumon entre 1990 et 2015 dans cette population de travailleurs a été déterminée grâce au fichier des tumeurs de l'Ontario. L'étude rapporte un taux d'incidence du cancer du poumon de 120 par 100.000 personnes-années chez ces travailleurs, alors que les statistiques provinciales canadiennes rapportent un taux d'incidence du cancer du poumon chez les hommes de 40 à 59 ans de 75 par 100.000 personnes-années, indiquant un risque relatif à la population de 1,60. De quel type d'étude s'agit-il ?

- ☒ Cohortive
- ☒ De cohorte
- ☒ Épidémiologie
- ☒ Transversale

66
L'APP
MC-A



Un homme de 42 ans se présente aux urgences dans un état de grande agitation. Il ne dort que quelques heures par nuit depuis une semaine et a bousculé sa fille qui souhaitait le conduire à l'hôpital. Il exige de rencontrer Bill Gates, car il aimerait apporter des correctifs à Microsoft 10 et veut parler avec le tygné pour faire des rires chauffantes. Son discours est acrobaté. Il n'a aucun antécédent psychiatrique. Quel examen paraclinique feriez-vous en priorité ?

- ☒ Catéchisme
- ☒ ECG
- ☒ Tomodensitométrie cérébrale
- ☒ TSH

67
L'APP
MC-A



Une femme de 19 ans se présente pour des idées suicidaires. Elle vous explique avoir des fluctuations importantes de ses émotions depuis l'enfance, ayant vécu de la violence à son jeune âge. Elle décrit également un sentiment de faiblesse estimée de soi au long cours et une sensibilité importante au rejet dans ses relations interpersonnelles. En plus d'avoir des antécédents de consommation de drogues et d'abus d'alcool, vous notez des consultations ambulatoires pour des épisodes d'insomnie depuis l'âge de 14 ans, jusqu'à des symptômes associés elle vous recontacte pour confirmer votre diagnostic ?

- ☒ Être observée dans ses relations intimes par coïté du réseau
- ☒ Respect rigide de certaines valeurs morales
- ☒ Entend à ce que tout lui soit dû sans raison spécifique
- ☒ Sentiment de coïté et de vide chronique

68
L'APP
MC-A



Une patiente de 69 ans connue pour une maladie tégumentaire est hospitalisée en orthopédie suite à une fracture de fémur lors d'une chute. En feuilletant, vous notez un tremblement de repos à son membre supérieur droit, un malchanceux involontaire et une tendance à lire la langue. Quelle serait votre première intervention pharmacologique pour l'aider ?

- ☒ Augmenter la dose de son stabilisateur de l'humeur
- ☒ Réduire de la benzodiazépine
- ☒ Diminuer la dose de son neuroleptique
- ☒ Remplacer son neuroleptique par de la clozapine

69
L'APP
MC-A



Une patiente en observation à l'urgence psychiatrique suite à une tentative de suicide par laceration superficielle aux poignets ultime le diable parmi l'équipe de soins. Alors qu'elle est gentille et collaborative avec certains, elle est opposante, agressive et virulente envers d'autres. Quel mécanisme de défense est en œuvre ?

- ☒ Chantage
- ☒ Déni
- ☒ Idéalisation
- ☒ Refuslement

70
L'APP
MC-A



Un homme de 24 ans consulte à votre bureau. Il y a un mois, il était présenté aux urgences après avoir ressenti des palpitations importantes avec oppression thoracique, tremblements et bouffées de chaleur. L'investigation cardiaque et pulmonaire vides avérés sans particularité. Depuis, il est incapable de sortir de chez lui craignant une récurrence de cet épisode, il a peur de perdre conscience ou de ne pas pouvoir avoir de facile et se fait lui-même de nouveau. Laquelle de ces investigations est indiquée dans votre bilan préliminaire ?

- ☒ Dosage de la créatinémie sérique
- ☒ Dosage de la sérotonine urinaire
- ☒ Dosage de la TSH sérique
- ☒ Dosage du cortisol sérique

71
L'APP
MC-A



Un patient de 23 ans arrive dans un état de grande agitation dans l'urgence où vous travaillez. Il est agressif, ote, se débat et est convaincu que des araignées et des vers rampent sous sa peau. Avec quel produit a-t-il le plus de chance d'être traité ?

- ☒ Alcool
- ☒ Cannabidiol
- ☒ Naloxone
- ☒ Méthamphétamine

72
L'APP
MC-A



En quittant votre bureau, un patient de 48 ans que vous suivez pour dépression vous confie que depuis des mois il est incapable d'atteindre l'orgasme lors de relations sexuelles. Quelle serait la meilleure intervention ?

- ☒ Aggraver du sildenafil
- ☒ Demander une plethysmographie pénienne
- ☒ Modifier son traitement antidépresseur
- ☒ Renvoyer à une technique pour thérapie comportementale

73
L'APP
MC-A



Malgré une investigation normale, un patient de 38 ans demeure convaincu que ses reins sont atrophiés en raison d'une panne de connexion entre son hypophyse et son hypothalamus et son hypothalamus est classé à une date de fromage cottage rancie et de pâtes pour éviter l'urémie fébrile, qui selon ses dires a emporté son frère. Malgré tout, il maintient son emploi et se rend à domicile de façon autonome. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Dépression psychotique
- ☒ Hypochondrie
- ☒ Schizophrénie hébéphrénique
- ☒ Trouble délirant

74 2 points
MC A



Un homme de 30 ans arrive à l'urgence avec un Glasgow à 8 (E2, V2, M2), TA 110/60, FC 60/min, FR 8/min, saturation à 98% et température rectale 36 °C. Il renifle. Ses pupilles sont en myosis. Vous savez qu'il a appelé sa conjuguée lui disant qu'il allait mettre fin à ses jours en prenant des médicaments et sa possession il y a 30 minutes. Vous n'avez aucune information sur la nature des médicaments. Que suspectez-vous ?

- ☒ Intoxication aux barbituriques
- ☒ Intoxication aux neuroleptiques
- ☒ Intoxication aux neurologiques
- ☒ Intoxication d'un médicament de la classe des cholinergiques

75 2 points
MC A



Quel terme décrit le mieux l'état suivant d'un patient souffrant de schizophrénie : « Tout a commencé très vite, je me remémore et me déballe, je suis comme un hélicoptère et j'ai même mon niveau est bleu ».

- ☒ Association par association
- ☒ Fuite des idées
- ☒ Relâchement des associations
- ☒ Tangentialité

76 2 points
MC A



Un enfant de 7 ans consulte avec ses parents pour un problème du sommeil. Dans le premier tiers de la nuit, il lui arrive de s'éveiller en poussant un grand cri, semble terrorisé, est en sueur et ne répond pas aux tentatives pour le réconforter. Le lendemain matin, il n'a pas souvenir de l'épisode, et d'un réveil lui ayant fait peur. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Cauchemars
- ☒ Narcolepsie
- ☒ Somnambulisme
- ☒ Tumeur nasale

77 2 points
MC A



Depuis plusieurs mois, un jeune homme de 24 ans a quitté son emploi au gouvernement, car il était convaincu qu'un réseau propagandiste anarchique prenait le contrôle de la direction et pouvait éventuellement menacer sa vie. Il est retourné habiter chez ses parents, ne voit plus ses amis et passe la nuit à écouter de la musique sur internet, y décode des messages politiques cachés. Depuis peu, la voix de son grand-père dédaigné lui ordonne de se brûler avec son mégot de cigarette « pour annuler les stigmates ». Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Maladie affective bipolaire, épisode de manie psychotique
- ☒ Schizophrénie paranoïde
- ☒ Trouble délirant, type paranoïde
- ☒ Trouble schizo-affectif, type dépressif

78 2 points
MC A



Vous rencontrez une patiente de 70 ans qui affirme que son mari n'est pas vraiment son mari et que son véritable mari est un être supérieur duquel elle a eu plusieurs fausses couches, mais dont les enfants sont toujours vivants. Les voix de sa belle-famille parlent constamment à ses oreilles et elle les accuse de faire le trafic d'opium. Quand son enfant était bébé, ses voix, déjà présentes, lui donnaient l'ordre de le tuer, ce à quoi elle résistait. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Paranoïde fébrile
- ☒ Schizophrénie
- ☒ Trouble délirant mystique
- ☒ Trouble neurocognitif majeur secondaire à la maladie d'Alzheimer

79 2 points
MC A



Une femme a une faiblesse extrême d'elle-même et fonde celle-ci de façon excessive sur son poids (IMC à 26). Elle fait des efforts pour restreindre son alimentation et adopte certains comportements comme l'activité physique pour compenser les épisodes fréquents pendant lesquels elle engloutit en quelques heures des kilos de nourriture riche et sucrée pour ultérieurement les vomir. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Anorexie, avec crises de boulimie et vomissements
- ☒ Boulimie
- ☒ Hyperphagie boulimique
- ☒ Impulsivité alimentaire liée à la personnalité limite

80 2 points
MC A



Une femme de 70 ans a vécu récemment le deuil de son mari. Bien qu'elle arrive à relativement bien fonctionner, elle souffre de difficultés d'endormissement importantes. Elle aimerait temporairement une méditation pour l'aider à dormir. L'un de ces médicaments aurait pour elle le meilleur profil d'effets secondaires ?

- ☒ Doxépine
- ☒ Méthine de chloral
- ☒ Champagn
- ☒ Quétiapine

81 2 points
MC A



Un adolescent est amené par sa mère à la clinique parce qu'elle a recouvert du cannabis dans son tiroir. Il est un adolescent sans trouble du comportement et réussissant bien à l'école. Il a horne et jure récent essayé qu'une fois ou deux. Sa mère exige quand même qu'il intègre une thérapie. Quelle serait la meilleure intervention à se poser ?

- ☒ Rassurer la mère à une psychologue
- ☒ Discuter des risques et conséquences de la consommation de drogues chez l'adolescent et des indices de dépendance
- ☒ Procéder à un test de dépistage des drogues de rue
- ☒ Proposer à l'adolescent d'intégrer un groupe de thérapie externe pour l'usage de drogues chez les adolescents

82 1 point
MCQ



Une patiente de 82 ans est hospitalisée pour diminution de l'état général. Après quelques jours à l'hôpital et bien que ses bilans ne soient pas perturbés, elle présente progressivement tachycardie, diarrhées, nervosité, tremblements et confusion aigüe. Quels duquel de ses médicaments est le plus probablement en cause ?

- ☒ Clonazepam
- ☒ Diméthylsulfoxyde
- ☒ Furosemide
- ☒ Mirtazapine

83 1 point
MCQ



Un homme a une longue histoire de dépendance au fentanyl acquise initialement lors du traitement de lombalgies. Il développe sur le marché noir et le consommé de toutes les façons possibles, se triquant même parfois. Il a développé une dépression majeure chronique et demande maintenant de l'aide pour reprendre sa vie en main. Quelle serait la meilleure approche ?

- ☒ Initier une thérapie dynamique longue afin d'aller à la racine commune de ces deux problèmes
- ☒ Traiter sa dépendance avant de traiter sa dépression, sans quoi les antidépresseurs n'auront pas d'effet
- ☒ Traiter sa dépression avant de traiter sa dépendance, afin qu'il ait suffisamment de motivation
- ☒ Traiter la dépression et la dépendance de façon intégrée

84 1 point
MCQ



Deux jours après une hémicolectomie, un patient de 59 ans présente un tableau d'agitation anxiieuse, tremblements, sudations, tachycardie et confusion. Lors de son évaluation préopératoire, il semble avoir minimisé sa consommation d'une substance, laquelle ?

- ☒ Rizol
- ☒ Amphetamine
- ☒ Cannabis
- ☒ Cocaine

85 1 point
MCQ



Un homme de 27 ans vous consulte, car il craint depuis 3 mois de se faire mal avec des objets coupants au point de s'empêcher d'en utiliser. Lorsqu'il voit un couteau, il a une image de lui se blessant avec et il a peur de ne pouvoir se retirer de faire le geste. Il vous assure cependant n'avoir jamais l'intention de se blesser volontairement. Il devient alors très anxieux et tente par divers moyens de chasser ces pensées sans succès. Lequel des traitements suivants vous semble être le meilleur choix ?

- ☒ Thérapie cognitive comportementale
- ☒ Thérapie de soutien
- ☒ Thérapie humaniste
- ☒ Thérapie interpersonnelle

86 1 point
MCQ



Une femme de 35 ans se présente à votre bureau pour un écoulement mammaire. Il s'agit d'écoulements bilatéraux blancs/bruns depuis plusieurs mois, sans douleur, ni masse associée. Elle n'a jamais eu de chirurgie mammaire et ne prend pas de médication. Elle a des menses irrégulières et des cycles prolongés depuis 2 ans. Quelle serait votre conduite ?

- ☒ Dosage prolactine et TSH
- ☒ Échographie mammaire
- ☒ Réassurance
- ☒ Mammographie

87 1 point
MCQ



Un homme de 51 ans se présente aux urgences pour des étourdissements importants depuis trois jours. Il dit que la pièce tourne autour de lui presque constamment et qu'il a couru à de multiples reprises. Il se plaint aussi d'entendre moins bien de l'oreille gauche depuis le début de ses étourdissements. Il n'a pas de bouillonnement d'oreille, ni de céphalée ni autre symptôme neurologique. À l'examen, le patient a de la difficulté à se tenir debout. Le moindre mouvement de la tête provoque un nystagmus horizontal avec phase rapide vers la droite. L'examen neurologique est normal par ailleurs. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Labyrinthite
- ☒ Lésion du tronc cérébral
- ☒ Maladie de Ménière
- ☒ Vertige positionnel paroxysmique bénin

88 1 point
MCQ



Un homme de 68 ans se présente aux urgences pour des vomissements sanguins. Il s'agit d'un premier épisode du genre. Il est fumeur et consommé de l'alcool à l'occasion. Il est connu pour de l'hémorie et un infarctus ancien. Signes vitaux : TA 100/60 FC 110/min. À l'examen, les sclères sont pâles et il est en diaphorèse. L'hémoglobine est mesurée à 95 g/L (normale : 140-180). Quelle devrait être la prise en charge ?

- ☒ Réhydratation IV
- ☒ Gastroscopie urgente
- ☒ Installation urgente d'un stent cardiaque en radiologie intervention
- ☒ CT thoracique et abdominopelvienne

89 1 point
MCQ



Un homme de 76 ans se présente aux urgences pour des saignements. Il s'agit d'un premier épisode du genre. Il est connu pour de la fibrillation auriculaire et s'écoule de la merfenne. Il a eu une coloscopie il y a 3 ans où une diverticulose a été notée et un polype tubulaire de 7 mm excisé au colot droit. Il n'a pas noté de changement au niveau de ses selles. Il ne présente aucune douleur abdominale. Signes vitaux : TA : 100/60 FC : 125/min. Le toucher rectal révèle du sang rouge clair sans autre anomalie. Son hémoglobine est mesurée à 89 g/L (N : 140-180). Quel devrait être le traitement initial ?

- ☒ Angio-transcathétérisme abdominopelvienne
- ☒ Coloscopie urgente
- ☒ Coloscopie et contrôle du saignement
- ☒ Stabilisation et correction des paramètres de coagulation

90
Léon
MC-A



Un homme de 55 ans se présente aux urgences pour gastroscopie, notée par sa corpore depuis quelques semaines. Il se plaint de dérangements depuis quelques mois. Il n'a pas de douleur abdominale, mais se plaint de mal de dos. Il n'a pas d'antécédents de chirurgie abdominale. Il rapporte une perte de poids d'environ 5 kg depuis 2 mois. À l'arrivée ses signes vitaux sont normaux. Une échographie démontre une vésicule biliaire dilatée avec des chofolliastes et une dilatation des voies biliaires intra et extra hépatiques. Quelle est la prochaine étape ?

- ☒ Cholangiopancréatographie rétrograde par endoscopie (ERCP)
- ☒ Ultrasun abdominal
- ☒ Tomodensitométrie abdominale
- ☒ Sonographie hépatobiliaire

91
Léon
MC-A



Une femme de 52 ans consulte pour une lésion acrochroïde, légèrement ulcérée du mamelon et de l'aréole du côté gauche, depuis six mois. Elle se plaint de prurit et de brûlure du mamelon ainsi que d'un écoulement jaunâtre. Il n'y a pas de masse palpable dans le sein. Que suspectez-vous en premier lieu ?

- ☒ Carcinome infiltrant du sein
- ☒ Dermite érythémateuse
- ☒ Dermite de contact
- ☒ Maladie de Paget du mamelon

92
Léon
MC-A



Un homme de 62 ans consulte à votre bureau en raison de troubles digestifs vagues ayant débuté 3 à 4 mois. Il présente une satiété précoce et a perdu 2 kg. Il n'a aucun antécédent. Quelle serait votre investigation à cette étape-ci ?

- ☒ Radiographie de l'abdomen
- ☒ Gastroscopie
- ☒ CT de l'abdomen
- ☒ Transit digestif supérieur

93
Léon
MC-A



Une patiente de 40 ans se présente aux urgences pour une douleur aigue depuis 48 heures. Il s'agit d'un premier épisode. La douleur est constante avec exacerbation lors du passage des selles. Signes vitaux : température 38,9°C, TA 120/70, FC 100/min. L'examen péni anal révèle une rougeur cutanée et une voussure au niveau de la fosse ilio-costale gauche ainsi qu'une fluctuation à la palpation. Quel est le meilleur traitement ?

- ☒ Antibiotiques IV
- ☒ Drainage en salle d'opération
- ☒ Drainage en radiologie
- ☒ Fistulotomie

95
Léon
MC-A



Vous êtes appelé à la salle de réveil pour voir un patient de 18 ans en post-opératoire d'une réduction ouverte en fixation interne d'une fracture du fémur sans complication. Il aurait perdu environ 400 ml de sang per opératoire. Son infirmière vous a rapporté parce que sa TA est rapidement descendue à 70/40 mmHg, avec FC 80/min, FR 20/min et SpO_2 90% (O_2 à 3L). Quelle est la cause la plus probable ?

- ☒ Anurie
- ☒ Anaphylaxie
- ☒ Embolie graisseuse
- ☒ Hémorragie

96
Léon
MC-A



Un homme de 52 ans se présente aux urgences pour une douleur au fémur gauche intense d'apparition subite, irradiant au testicule gauche. Il a remarqué du sang dans ses urines lors de sa dernière miction. Il est très souffrant et inconfortable. Quelle serait la meilleure investigation ?

- ☒ Radiographie méso et urétéro
- ☒ Urographie intraveineuse
- ☒ Uro-tomodensitométrie (urétéro) avec contraste IV
- ☒ Uro-tomodensitométrie (urétéro) sans contraste IV

97
Léon
MC-A



Une patiente de 72 ans se présente aux urgences pour douleur abdominale qui a débuté il y a 18 heures. Elle est souffrante et un peu confuse. Signes vitaux : TA 95/65, FC 120/min et température rectale 38,4°C. À l'examen physique, la patiente est tachyque, avec une distension au quadrant supérieur droit de l'abdomen. Au bilan initial : bilirubine totale 32 $\mu\text{mol/L}$ (N : 5-21), indoxure 16 (N : 1-16), directe 16 (N : 0-4). Quelle est la meilleure conduite ?

- ☒ Cholangiopancréatographie rétrograde par endoscopie (ERCP)
- ☒ Cholangio-pancréatographie par IRM (MRCP)
- ☒ Cholangiectomie
- ☒ Cholangioscintiscie

98
Léon
MC-A



Un garçon de 12 ans consulte aux urgences pour douleur progressive à la jambe gauche depuis quelques semaines. Il a noté cette douleur peu après une chute à vélo. La douleur est constante, mais pire à la marche et la nuit. Les signes vitaux sont normaux. À l'examen, lors de la palpation de la jambe proximale, vous palpez une masse ferme ; la peau est normale. Vous avez demandé une radiographie (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quelle est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Fracture de stress
- ☒ Osteomyélite
- ☒ Osteochondrome
- ☒ Osteosarcome

99
Léon
MC-A



Un homme de 35 ans se présente aux urgences pour douleur à l'avant-bras gauche. La douleur est apparue il y a 24 heures et est progressivement devenue très intense, maintenant 10/10 ; elle est augmentée par la mobilisation des doigts. Il ne rapporte aucun traumatisme. Signes vitaux : température 38,8°C, TA 120/80 et FC 114/min. À l'examen physique, vous notez un érythème mal délimité d'environ 8 cm sur la face dorsale de l'avant-bras gauche. La palpation de l'avant-bras est extrêmement douloureuse. Quelle est la conduite prioritaire à ce stade-ci ?

- ☒ Échographie de surface de l'avant-bras
- ☒ Exploration chirurgicale
- ☒ Imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'avant-bras
- ☒ Tomodensitométrie de l'avant-bras

100
Léon
MC-A



Un garçon de six ans est amené aux urgences à cause d'une violente douleur à la région crurale droite apparue subitement. Cette douleur s'accompagne de gonflement et de rougeur. Vous notez à l'examen une sensibilité diffuse et un testicule droit augmenté de volume ligé dans la partie supérieure du scrotum. Quelle sera votre conduite ?

- ☒ Antibiothérapie
- ☒ Consultation urgente en urologie/chirurgie
- ☒ Dosage des enzymes urinaires
- ☒ Échographie testiculaire

101

1 point
MCQ



Une femme de 55 ans consulte pour une bosse au sein droit qu'elle a remarquée depuis quelques mois. Vous palpez un nodule ferme et peu mobile d'environ 1.5 cm au quadrant supérieur externe du sein droit. Il n'y a pas d'auréole massée dans les seins, ni d'adénopathie axillaire. Le mammographie démontre un nodule, qui était absent à la mammographie de dépistage il y a deux ans. À l'échographie ce nodule est solide. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☐ Carcinome du sein
- ☒ Fibroadénome
- ☐ Papillome
- ☐ Tumeur phyllode

102

1 point
MCQ



Un tumeur de 68 ans se plaint d'une douleur intermittente au mollet droit, survenant après une marche de 20 m. Il a également de la douleur nocturne et parfois au repos et les symptômes sont présents depuis 6 mois. À l'examen, on ne sent pas de poulx fémoral droit. L'angiographie montre une occlusion de l'artère fémorale commune sur un court segment avec un bon lit distal (artères distales perméables). En plus de cesser de fumer, laquelle des conduites suivantes est la plus appropriée ?

- ☐ Angioplastie fémorale
- ☒ Marche quotidienne jusqu'à disparition de la douleur
- ☐ Pontage fémoro-fémoral
- ☐ Traitement par un vasodilatateur

103

1 point
MCQ



Un homme de 18 ans consulte sans rendez-vous pour douleur thoracique rétro sternale, dyspnée et toux sèche depuis 2 mois. Il se plaint aussi de fatigue progressive et perte de poids d'environ 8 kg. La revue des systèmes est par ailleurs négative. Les signes vitaux sont normaux. L'examen physique est normal. Vous avez demandé une radiographie (voir RADIOGRAPHIE). Quelle est la cause la plus probable ?



- ☐ Ostéite pléurale
- ☐ Lymphome
- ☐ Thymome
- ☒ Ténosynovite

104

1 point
MCQ



Une femme de 66 ans se présente dans votre bureau en raison d'une bosse à son cou. Elle est en bonne santé, sans antécédents médicaux et asymptomatique. L'examen physique révèle un nodule d'environ 1.5 cm au lobe droit de la glande thyroïde. Il n'y a aucune adénopathie palpable à la région cervicale. Quelle serait votre conduite à cette étape-ci ?

- ☒ Biopsie à l'aiguille fine
- ☐ Consultation en ORL
- ☒ Échographie thyroïdienne
- ☐ CT scan cervicale

105

1 point
MCQ



Vous avez évalué un patient de 22 ans pour une masse testiculaire à l'hémiscrotum droit. Elle est facilement palpable en position couchée, sans changement de taille au Valsalva, ni en position debout. L'échographie démontre une varicocèle droite (le testicule droit est un peu plus petit que le gauche, mais de texture normale sans masse) ; du côté gauche, il n'y a pas de varicocèle et le testicule est normal. Quelle est votre conduite ?

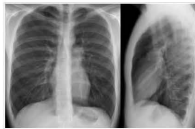
- ☒ Consultation pour chirurgie
- ☐ Réassurance, support scrotal et ARO si douloureux
- ☐ Spermogramme
- ☐ CT scan abdominale

106

1 point
MCQ



Une femme de 22 ans, se présente aux urgences dans le contexte d'une dyspnée et d'une douleur thoracique d'apparition subite. Elle raconte avoir ressenti une douleur thoracique droite aigue pendant son entraînement de basketball. Il n'y a pas d'antécédents médicaux particuliers. À l'examen, la fréquence cardiaque est à 100/min, la TA est à 130/80 et la fréquence respiratoire est à 24 par minute. Le palpation thoracique droite est douloureuse et l'auscultation pulmonaire est normale. Vous avez demandé une radiographie pulmonaire (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quelle est votre principale hypothèse diagnostique ?



- ☒ Déchirure musculaire
- ☐ Embolie pulmonaire
- ☐ Fracture de côtes
- ☐ Pneumothorax

107

1 point
MCQ



Vous évaluez un patient agité qui a subi un traumatisme au bras suite à une chute. Vous avez sa radiographie (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quelles-vous rechercher spécifiquement à l'examen neurologique ?



- ☒ Pallesthésie de l'adduction et abduction des doigts
- ☐ Pallesthésie de la flexion du coude
- ☒ Pallesthésie de la flexion du poignet
- ☐ Pallesthésie de l'extension du poignet

108

1 point
MCQ



Un homme de 28 ans est amené aux urgences suite à une altercation dans un bar. Il est conscient, mais agité et sent fatigué. Il rapporte avoir été poignardé à l'abdomen il y a environ 30 minutes. Signes vitaux : TA 130/75, FC 90/min, SpO2 88% (en ambiant). L'examen révèle une lésion abdominale au quadrant inférieur droit de 3cm avec protrusion d'un peu d'égérogène ; pas de péritonisme. Quelle devrait être la prochaine étape ?

- ☒ Échographie en radiologie
- ☒ Exploration abdominale au bloc opératoire
- ☒ Observation avec examens physiologiques sériés
- ☐ Lavage péritonéal

109

1 point
MCQ



Un patient de 24 ans est amené aux urgences suite à une chute du 2ème étage. À son arrivée il est conscient, mais un peu désorienté et il sent fatigué. Il se plaint de douleur cervicale, ne peut bouger ses 2 jambes et il bouge difficilement les bras. Signes vitaux : TA 85/60, FC 60/min, FR 16/min, saturation SpO2 98% avec masque O2 2L/min. L'abdomen et le bassin ne sont pas douloureux. La radiographie pulmonaire est normale. L'échographie diagnostique à l'urgence ne révèle pas de liquide libre intra abdominal. Il y a une déformation de la colonne droite et plusieurs plaques superficielles. Quelle est la cause la plus probable de l'hyperextension ?

- ☒ Fracture du fémur
- ☒ Hémorragie méningée péritonéale
- ☒ Traumatisme médullaire
- ☐ Traumatisme splénique

110

1 point
MCQ



Un homme de 65 ans se présente aux urgences pour raoules et constance. Ses symptômes ont débuté il y a trois jours. Il n'a pas eu de selles, ni de gaz depuis. Il est connu pour diabète et a déjà subi une appendicectomie par laparoscopie il y a 10 ans. À l'examen, le patient présente des signes de déshydratation et un abdomen globuleux sans signe de péritonisme. Vous avez sa radiographie abdominale (voir RADIOGRAPHIE jointe). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Néux colique sur cancer colocolonectomisé
- ☐ Néux colique sur adhérence
- ☐ Néux colique du sigmoïde
- ☐ Syndrome d'Ogilvie

111

1 point
MCQ



Un garçon de 12 ans se présente aux urgences pour des diarrées sanglantes depuis 48 heures. Il est en bonne santé par ailleurs. Il répond avoir participé à un pique-nic 2 ou 3 jours avant le début des symptômes. Il ne présente pas de constance. Il signale des crampes abdominales avant d'aller à la selle et environ 1 épisode de diarrhée par jour. Signes vitaux : température 37,8°C, FC 90/min et TA 112/70. Le temps de recoloration capillaire est inférieur à 2 secondes et les extrémités sont chaudes. L'examen de l'abdomen est normal. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Antibiotique
- ☐ Coloscopie
- ☐ Culture de selles et observation
- ☐ Schédu IV aux besoins d'électrolytes

112

1 point
MCQ



Vous voyez une fille de 18 mois pour son suivi régulier. Les parents, dont elle est le premier enfant, s'inquiètent quant à l'acquisition du langage. Elle dit de façon compréhensible « maman », « papa », « fat », « encore », « non », « dodo » et « toutou ». Elle ne joint pas 2 mots ensemble. Elle comprend les consignes simples, mais pas les consignes complexes. Comment dictez-vous le développement du langage chez cette patiente ?

- ☐ Langage normal
- ☒ Retard de langage expressif seulement
- ☐ Retard de langage réceptif seulement
- ☐ Retard de langage réceptif et expressif

113

1 point
MCQ



Un enfant de 3 ans, non vacciné, est amené aux urgences pour détresse respiratoire. Les parents rapportent un rhume dans les jours précédents et de la fièvre à 38,5°C. Il présente un sifflement à un tirage modéré et une dyspnée expiratoire. La SpO₂ est de 90% à l'air ambiant. Outre l'oxygénothérapie, quelle sera votre prise en charge initiale ?

- ☒ Antibiotique IV
- ☐ Antibiotique IV et consultation urgente en ORL
- ☐ Déaméthasone PO
- ☐ Déaméthasone PO et épinéphrine en nébulisation

114

1 point
MCQ



Un fillette de 5 ans, en bonne santé, présente depuis 3 mois des lésions sur le ventre (voir PHOTO jointe) qui augmentent graduellement en taille. Elles ne sont ni douloureuses, ni prurigineuses. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☐ Herpès simplex
- ☒ Folliculite
- ☐ Molluscum contagiosum
- ☐ Uncoïte

115

1 point
MCQ



Un garçon de 8 ans présente depuis 3 jours une toux et un gonflement de l'œil droit (voir PHOTO jointe). À l'examen, vous notez des mouvements oculaires diminués et douloureux. Sa température rectale est 38,5°C. Quel est la prise en charge initiale appropriée ?



- ☒ Antibiotique IV
- ☐ Antibiotique PO
- ☐ Incision et drainage
- ☐ Onguent antibiotique topique

116

1 point
MCQ



Des parents se présentent avec leur fillette de 6 mois pour de la difficulté respiratoire. Elle avait un rhume depuis quelques jours et les parents ont remarqué un tirage respiratoire quelques heures avant de consulter. La patiente n'a pas d'emboulement particulier. Le père fume de l'herbe en bas âge. Il fume du premier épisode du genre. La patiente est alerte. Sa fréquence respiratoire est de 40/min. Vous remarquez un tirage modéré sous-costal et sus-sternal. Elle n'a pas de battements des ailes du nez ni de wheezing. Le murmure vésiculaire est symétrique et il y a des sibilances et des ronchi sont entendus en fin d'expiration. La SpO₂ est de 96% à l'air ambiant et elle vous apparaît congestionnée. Quelle sera votre prise en charge immédiate ?

- ☒ Oxygénothérapie
- ☐ Prednisolone per os
- ☐ Tixéte nasale
- ☐ Salbutamol en nébulisation

117

1 point
MCQ



Vous êtes à la bureau d'un garçon de 18 mois. Il n'a pas d'emboulement particulier, sauf une otite vers 12 mois. Développement physique est normal. Au niveau du langage, il dit « maman », « papa » et « lat » et tend la main vers les objets qu'il désire. Il suit les consignes simples si elles sont accompagnées de gestes. Les parents le décrivent comme timide. Le père rapporte qu'il était comme lui en bas âge. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Évaluation en audiologie
- ☐ Évaluation en orthophonie
- ☐ Évaluation pour un trouble du spectre de l'autisme
- ☐ Réassurance

118

1 point
MCQ



Des parents consultent avec leur nourrisson de 9 mois. Il n'a pas d'emboulement particulier. Son poids de naissance était de 3,6 kg. Le reste des symptômes par système est négatif. Les signes vitaux sont normaux. L'examen physique est dans les limites de la normale, sauf pour une certaine malnutrition. Il aurait été allaité jusqu'à 2 mois. Les solides ont été débutés vers 4 mois. Selon les parents, il semble rassasié à la fin des repas. Il boit 450 ml de préparation pour nourrissons à 70 calories/100 ml par jour. Il mange des céréales le matin avec l'équivalent d'un cube de fruits (15 ml), son alimentation comporte de la viande (environ 15 g) et des légumes (environ 15 g) aux principaux repas. Il boit 150 ml de jus de fruits à chaque repas. Le percentile de poids serait passé du 65^e au 20^e percentile dans les derniers mois. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Recommander d'augmenter la quantité de lait par jour
- ☐ Recommander d'utiliser un lait plus calorique
- ☐ Recommander d'augmenter les portions de solides
- ☐ Recommander de diminuer la quantité de jus de fruits

119 1 point
MCA



Une jeune fille de 18 mois se présente au bureau pour une otite à l'oreille gauche depuis 24 heures. Elle est congestionnée depuis quelques jours et a de la rhinorrhée claire. Il n'y a pas d'otite et la température est de 38,5°C. Elle conserve un bon état général. Le père vous rapporte qu'elle aurait pris de la claritromycine il y a 1 mois pour une bronchite. L'examen du tympan est le suivant (voir photo). Quelle sera votre conduite ?



- ☒ Amoxicilline po 45 mg/kg/jour
- ☒ Amoxicilline po 90 mg/kg/jour
- ☒ Ceftriaxone IM pour 3 jours
- ☐ Observation en réassurance

120 1 point
MCA



Vous voyez une adolescente de 16 ans qui vient de déménager dans votre région, car elle est inquiète de ne pas encore avoir eu ses règles. Elle rapporte également des difficultés scolaires. À l'examen, elle est de petite taille et démontre de l'embonpoint (voir PHOTO jointe). La revue des systèmes est sans particularité. Quelle investigation allez-vous demander pour confirmer votre impression diagnostique ?



- ☒ Caryotype
- ☒ CGH
- ☒ FISH pour trisomie 21
- ☒ Recherche de S-Fragile

121 1 point
MCA



Vous êtes appelé à la pépinière pour évaluer un nouveau-né de 12 heures de vie pour hypotonie et difficultés aux tétées. Il est né d'une grossesse normale, en dehors de l'existence d'un polyphylomies. Découchement s'est également déroulé normalement. Le score d'Apgar était de 9-10 et le poids de naissance de 2,2 kg. Les signes vitaux sont normaux. Le glycémie est de 3,0 (N : 2,6-5,0). L'examen physique est remarquable pour une hypotonie importante et une respirabilité à gauche. Quel bilan initial allez-vous demander pour confirmer la cause la plus probable de l'hypotonie ?

- ☒ Hybridation génomique comparative (CGH)
- ☒ Dosage de la T7OH pré-génération
- ☐ Dosage des CK
- ☒ Étude de la méthylation pour le syndrome de Prader-Willi

122 1 point
MCA



Vous évaluez au bureau un garçon de 18 mois. Il n'a pas d'embolisme particulier, sauf une otite vers 12 mois. L'examen physique est normal. Au niveau du langage, il utilise de 10 à 15 mots. Il n'associe pas deux mots ensemble. Les parents le décrivent comme timide. Le père rapporte qu'il était comme lui en bas âge. Quelle sera votre conduite initiale ?

- ☒ Évaluation en audiology
- ☒ Évaluation en orthophonie
- ☒ Évaluation en pédiopsychiatrie
- ☒ Réassurer et revoir pour suivi

123 1 point
MCA



Vous voyez en clinique un garçon de 10 ans pour son suivi périodique. Selon sa mère, il n'est pas propre la nuit, mouille son lit environ 2 fois par semaine. Il est propre la jour depuis ses 3 ans. Il n'a pas de symptôme d'infection urinaire, ni d'incontinence fécale. Son examen physique est normal. Quel serait la meilleure conduite ?

- ☒ Calécitane mictionnel
- ☒ Desmopressine
- ☒ Oxybutrine
- ☒ Syndrome d'alarme mictionnelle

124 1 point
MCA



Vous voyez un nouveau-né de 36 heures de vie avec tétée latente. Il est né à 36^{se} semaines d'une grossesse sans particularité. La mère était positive de Streptocoque du groupe B, mais a reçu une antibiothérapie adéquate. Outre l'ictère, l'examen du bébé est normal et il n'y a pas de déshydratation. Il est allaité exclusivement et il tète bien. Les selles et les urines sont normales. La bilirubine sérique est de 275 µmol/L normale : < 175 µmol/L. Quelle sera votre conduite ?

- ☒ Débuter une photothérapie
- ☒ Débuter des antibiotiques IV
- ☒ Donner des suppléments de lait maternel
- ☒ Observer, avec contrôle de la bilirubine dans 12 heures

125 1 point
MCA



Vous êtes en garde comme médecin accoucheur dans un centre hospitalier pédiatrique. Une jeune femme de 17 ans se présente en travail actif. Elle n'aurait pas eu de saut périlleux, mais vous calculez qu'elle semble à terme avec la date de ses dernières menstruations et sa hauteur utérine. L'accouchement se déroule sans problème. Le liquide amniotique est clair. Le poids de naissance est de 3,4 kg et l'APGAR de 9-10. Dans les minutes qui suivent la naissance, le nouveau-né développe un bruyant et un battement des ailes du nez et un grunting. Il n'a pas de cyanose. Sa fréquence respiratoire est de 80/min. La saturation de l'hémoglobine en oxygène est de 90% à l'air ambiant. L'antécédent d'air est documenté à droite. Vous demandez une radiographie pulmonaire. À la lecture de cette radiographie et de la clinique du patient, quelle sera votre prise en charge initiale ?



- ☒ Débuter des antibiotiques à large spectre
- ☒ Installer un drain thoracique
- ☒ Insérer le patient
- ☒ Transférer pour consultation en chirurgie pédiatrique

126 1 point
MCA



Des parents consultant à l'urgence de votre hôpital pensent que leur garçon de 7 mois a des crises de pleurs inévitables. Il est alimenté par une préparation pour nourissons à base de protéines de lait de vache et a commencé les solides d'orge. Il présente des crises de pleurs depuis 24 heures et ne, à intervalle de 15 à 30 minutes. Il régresse un peu comme à l'habitude et il avale un épais de vomissements de lait dans la journée. Les parents rapportent qu'il met ses jambes en flexion sur sa poitrine lors des crises. Une selle avertit été mêlée avec du sang rouge écarlate et du mucus, que les parents rapportent à une petite fissure anale. Les signes vitaux et l'examen physique sont normaux, incluant l'examen de l'abdomen et le toucher rectal. Quelle sera votre prise en charge initiale ?

- ☒ Prescrire une analgésie et une culture d'urine
- ☒ Prescrire une échographie de l'abdomen
- ☒ Réassurance, car il s'agit probablement de coliques du nourrisson
- ☒ Suggester un lait d'hydrolysates de caséine

127 1 point
MCA



Une adolescente de 17 ans consulte aux urgences pour une plaie au talon gauche. Elle a marché sur un clou. Ses vaccinations sont à jour, sauf pour les vaccins préex en collège, quelle n'a pas reçu, étant malade à ce moment. Quelle sera votre conduite ?

- ☐ Immunoglobulines contre le tétanos
- ☒ Nettoyage de la plaie soigneusement
- ☒ Vaccin contre le tétanos
- ☒ Vaccin contre le tétanos et immunoglobulines contre le tétanos

128

1 point
MCQ



Vous voyez pour la première fois une fillette de 6 ans en vue d'un suivi périodique. Elle n'a pas d'antécédents particulier et le reste des systèmes est complètement régressif. Examen physique est remarquable par un B2 déboulé fixe et un souffle diastolique au 2^e espace intercostal gauche d'intensité à S4. Le reste de l'examen physique est normal. L'ECG montre un bloc de branche droit incomplet. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Canal aortique perméable
- ☒ Communication interauriculaire (CIA)
- ☒ Communication interventriculaire (CIV)
- ☒ Souffle cardiaque fonctionnel

129

1 point
MCQ



Une maman vous consulte avec sa petite fille de 10 mois qui dort peu la nuit depuis 2 mois. Elle se réveille à tous moments, alors qu'elle dormait sans problème auparavant. Par ailleurs, la maman vous parle de nouvelles lézions cutanées apparues dans la même période (voir PHOTO jointe), avec des crises de gémissements. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Dermatite atopique
- ☒ Gale
- ☒ Impétigo à staphylocoque aureus
- ☒ Pustulose pustuleuse

130

1 point
MCQ



Vous faites l'examen d'un nouveau-né de 8 heures de vie. Il est né d'une grossesse à terme et sans complications. Son poids de naissance est de 3 kg et son Apgar de 9/10. Il est alerte. Ses signes vitaux sont normaux. Les parents sont inquiets d'une lésion cutanée (phéno jointe). La lésion blanchit à la pression. Quelle sera votre conduite ?



- ☒ Consultation en dermatologie
- ☒ Consultation en ophtalmologie
- ☒ Imagerie par résonance magnétique cérébrale
- ☒ Réassurance

131

1 point
MCQ



Vous prenez la garde de l'aîné et préparez le sortie d'un bébé de 3 mois admis dans un contexte d'effoulement avec perte de tonus et changements de coloration, attribué à un reflux gastro-œsophagien. Uniquement avant d'aller de courte durée et il n'y a pas eu de récidive pendant l'observation de 24 heures. L'examen physique et les examens complémentaires étaient aussi normaux. Quels seront les conseils à donner aux parents ?

- ☒ Vous suggérez un monitoring d'apnée lors du sommeil
- ☒ Vous suggérez qu'il dorme sur le côté
- ☒ Vous suggérez qu'il dorme sur le dos, le tête légèrement surélevée
- ☒ Vous suggérez qu'il dorme le plus possible sur le ventre sous supervision

132

1 point
MCQ



Vous êtes de garde aux urgences et voyez un enfant de 11 mois amené par sa grand-mère maternelle inquiète de lézions au visage. Sa fille lui aurait expliqué que l'enfant était seul dans le salon sur son petit fauteuil en mousses (hauteur 30 cm) pendant qu'elle allait aux toilettes. Elle aurait entendu un « boum » et l'enfant pleurer pendant 2 minutes. L'enfant n'a pas d'antécédents particulier. Le reste des systèmes est sans grande particularité selon la grand-mère qui garde fréquemment l'enfant. Les signes vitaux sont normaux. L'examen physique est remarquable pour les lésions (voir photos jointes). L'examen neurologique est normal. Le Glasgow est de 15/15. L'enfant pleure pas souffrant et n'a pas de douleur au site d'abaissement des membres, du thorax et du crâne. Vous demandez une formule sanguine complète et un bilan de coagulation. Quelle sera votre prise en charge ?



- ☒ Consultation en ophtalmologie
- ☒ Consultation en ophtalmologie et radiographies osseuses
- ☒ Échographie transfontanelle
- ☒ Radiographie du squelette

133

1 point
MCQ



Des parents consultent aux urgences avec leur enfant non vacciné de 14 mois. Il aurait été fébrile avec une température enregistrée 39 °C et instable dans les 3 derniers jours. Il est congestif et présente une rhinorrhée importante. On note une éruption maculeuse qui a débouté au niveau de la tête et du cou (voir photo) pour ensuite s'étendre au tronc et aux membres. Ses conjonctives sont hyperémiques. Il est légèrement hypoxémique et sa température est de 38,7 °C. Vous êtes en attente des bilans. Quelle sera votre conduite ?



- ☒ Réassurance
- ☒ Traitement à l'émulsion
- ☒ Traitement à la ribavirine
- ☒ Traitement à la vitamine A

134 1 point

MCQ



Vous voyez à l'arrêt d'auscultation des urgences un enfant de 20 mois amené par ses parents car il se plaint de douleur au coude gauche depuis son retour de la garderie. Il refuse d'utiliser son bras. Vous ne remarquez pas d'œdème ni de déformation. Le gardienne aurait dit qu'un enfant plus âgé aurait peut-être été son bras lors d'un jeu de poursuite dans la cour. Le radiographe du coude montre une subluxation de la tête radiale. Vous réussissez à réduire facilement cette subluxation. Quelles sont vos investigations supplémentaires ?

- ☒ Aucune investigation
- ☒ Bilan phosphoréologique
- ☒ Bilan phosphoréologique, radiographies du squelette
- ☒ Bilan phosphoréologique, radiographies du squelette et résonance magnétique (IRM) cérébrale

135 1 point

MCQ



Un garçon de 13 ans consulte pour douleur à la hanche droite et boiterie depuis 3 semaines sans épisode fébrile. Il rapporte avoir chuté en vélo 1 semaine avant le début des symptômes. À l'examen physique, son membre inférieur droit est en rotation externe et en abduction de la cuisse. Que recherchez-vous spécifiquement à la radiographie de la hanche ?

- ☒ Élargissement de l'espace articulaire
- ☒ Fragmentation de la tête fémorale
- ☒ Grossissement épiphyse de la tête fémorale
- ☒ Signe du croissant

136 1 point

MCQ



Un patient de 52 ans consulte au sein d'un service neurologique pour une douleur à la nuque et une raideur à la nuque. Il a noté une perte de connaissance il y a 2 semaines. À l'examen physique, il présente une raideur à la nuque, un signe de Babinski à droite et une hypostase à gauche. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ West
- ☒ Rubeola
- ☒ Rubeola
- ☒ Rubeola

- ☒ Consultation élective en neurologie
- ☒ Consultation urgente en ORL
- ☒ Rassurer et réévaluer dans quelques jours
- ☒ Tomodensitométrie cérébrale

137 1 point

MCQ



Un patient de 50 ans fait une chute à bicyclette et heurte violemment le sol avec le côté gauche de la tête. Il n'a pas de perte de connaissance. Il est examiné aux urgences. Il présente un écoulement clair par le nez gauche, un hémorragie spontané à la base de la langue et un test de Weber latéral à droite avec une hypostase à gauche. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Fracture transverse du rocher gauche
- ☒ Fracture temporo-massétoïdienne gauche
- ☒ Fracture longitudinale du rocher gauche
- ☒ Commotion labyrinthique gauche

138 1 point

MCQ



Un enfant de 3 ans est amené en consultation suite à une toux persistante depuis 3 jours. L'examen clinique révèle une toux et une dyspnée nocturne. Il y a 4 jours lorsque l'enfant avait 2 ans, il a eu une toux et une dyspnée nocturne. Le radiographe du thorax est normal. Quelle est votre attitude ?

- ☒ Prescription d'un sirop contre la toux et d'un antipyrétique, contrôle à 48 heures
- ☒ Un traitement antibiotique et calmant
- ☒ Une corticothérapie
- ☒ Une bronchoscopie à la recherche d'un corps étranger

139 1 point

MCQ



Vous examinez un patient de 75 ans hospitalisé suite à un accident vasculaire cérébral ischémique. Il est hémiparétique, conscient, capable de s'exprimer, mais d'une voix faible, peu sonore, et présente des troubles sélectifs de la déglutition (fausses routes alimentaires et liquidiennes). Quelle action neurologique peut être à la fois responsable de sa dysphonie et de sa dysphagie ?

- ☒ Atrophie d'un nerf hypoglosse
- ☒ Atrophie d'un nerf vague
- ☒ Atrophie d'un nerf vague
- ☒ Atrophie d'un nerf facial

140 1 point

MCQ



À la suite d'un voyage en avion 3 jours auparavant, un patient de 50 ans consulte pour une obstruction nasale aiguë accompagnée d'une rhinorrhée purulente abondante, une sensation de pression sur le front et d'une anosmie. Il se sent très fatigué, mais n'a pas de fièvre ni de douleur. Il doit reprendre son travail rapidement, car il a une réunion importante dans 3 jours. Quelle est votre attitude ?

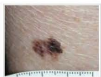
- ☒ Un bilan radiologique à but diagnostique est indiqué
- ☒ Une antibiothérapie doit être prescrite en plus du traitement symptomatique
- ☒ Traitement symptomatique : prescription d'un anti-inflammatoire, d'un analgésique, de gouttes décongestionnantes et de rinçage à l'eau salée
- ☒ Une ponction des sinus avec des rinçages

141 1 point

MCQ



Vous recevez en consultation un homme de 55 ans qui, à la demande de sa conjointe, voudrait que vous examiniez son dos pour lui faire une friction de la peau. Il ignore la présence de cette lésion avant que sa conjointe lui en parle. Vous remarquez une lésion sur la peau de son dos à la hauteur de la scapula (voir PHOTO jointe). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Carcinome basocellulaire nodulaire
- ☒ Mélanome mélanocytique
- ☒ Mélanome à extension superficielle
- ☒ Névus mélanocytique acquis

142 1 point

MCQ



Un patient de 72 ans vous consulte pour un abcès cutané non douloureux au pied droit depuis quelques semaines (voir photo). Elle est connue pour antécédents d'HTA, de diabète et d'embolie pulmonaire profonde il y a trois ans. Que suspectez-vous ?



- ☒ Carcinome basocellulaire
- ☒ Ulcère artériel
- ☒ Ulcère diabétique
- ☒ Ulcère veineux

143 1 point

MCQ



Vous recevez un patient de 27 ans. Il est en bonne santé mais souffre depuis 2 ans d'une dermatose extrêmement prurigineuse des mains avec de petites vésicules sur les faces latérales des doigts et parfois également des ongles. Vous devez considérer le diagnostic différentiel suivant, sauf un, lequel ?

- ☒ eczéma de contact toxique infantile
- ☒ dermatite atopique
- ☒ infection à Herpes simplex
- ☒ mycosite avec une réaction mycotique

144

1 point
MCQ



Un homme de 54 ans se présente à votre cabinet avec une lésion sur le nez (cf. image). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Carcinome spinocellulaire
- ☒ Carcinome basocellulaire
- ☒ Mélanome
- ☒ Mélasie actinique

145

1 point
MCQ



Un adolescent de 12 ans se présente avec des lésions faciales dans votre cabinet. L'inspection révèle un status du visage morré et dessous (voir également image projetée). Quel est le diagnostic le plus probable ?



- ☒ Une sclérose tubéreuse de Bourneville
- ☒ Une neurofibromatose de von Recklinghausen
- ☒ Un rhéodermie pigmentosum
- ☒ Une porphyrie cutanée aigue

146

1 point
MCQ



Un jeune homme de 20 ans se présente à votre consultation avec une ecchymose péri-orbitaire droite. Il a été victime d'une agression par coups de poing la veille à la sortie de discothèque. Il décrit un petard en bonne santé habituelle. Il décrit une vague douleur à l'œil droit avec une vision double depuis ce matin, quand il a réussi à ouvrir les yeux. Examen montre un hémorragie péri-orbitaire droit. La palpation du pourtour orbitaire est normale. Les pupilles sont symétriques. Douleur buccale rien pas brisée. Examen de l'acoustique est bilatérale et confirme de déficit de l'élévation de l'œil droit avec appétion de la diplopie. Il existe une hyposthésie dans le territoire du nerf infra-orbitaire droit. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Fracture du plancher orbitaire
- ☒ Fracture du zygoma
- ☒ Fracture de LeFort I
- ☒ Fracture du nez

147

1 point
MCQ



Six jours après une opération de cataracte de l'œil gauche, un patient de 70 ans se plaint de douleurs, photophobie et vision floue. La vision de l'œil gauche est de 6/10 alors qu'elle était de 8/10 le premier jour après l'opération. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Une uvéite antérieure aiguë HLA-B27
- ☒ Une endophtalmie bactérienne
- ☒ Une ophtalmie sympathique
- ☒ Un syndrome d'Imms-Zenker

148

1 point
MCQ



Un patient de 30 ans se présente avec une photophobie de l'œil droit. Examen de la chambre antérieure révèle un effet Tyndall de 3+ avec 3+ de cellules en chambre antérieure. Il n'y a pas de précipités en "graisse de mouton" sur l'endothélium corneal. Le vitré est calme et la rétine sans particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Une lézion vésiculaire herpétique
- ☒ Une hémorragie de Fuchs
- ☒ Une uvéite antérieure aigue
- ☒ Une uvéite intermédiaire

149

1 point
MCQ



Un patient de 67 ans présente une membrane épithéliale symptomatique à l'œil droit. Ses antécédents oculaires sont remarquables pour une opération oculaire il y a 2 ans à l'étranger. Laquelle des opérations suivantes n'est pas associée au développement secondaire d'une membrane épithéliale ?

- ☒ Cryochélie
- ☒ Opération filtrante pour glaucome à angle ouvert
- ☒ Vitrectomie pour membrane épithéliale
- ☒ Photocoagulation par laser

150

1 point
MCQ



Une personne de 75 ans se plaint de vision déformée de son œil droit depuis 2 mois. Elle a des difficultés de lecture. A l'examen, on constate une hémorragie maculaire. La pupille est bien colorée. La rétine périphérique ne montre aucune particularité. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- ☒ Une occlusion de la veine rétinienne centrale
- ☒ Une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type atrophique
- ☒ Une dégénérescence maculaire liée à l'âge de type exsudative
- ☒ Une maculopathie diabétique